SKRIPSI

GAMBARAN FAKTOR PENYEBAB KEJADIAN ISPA PADA LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PASSO

OLEH :

Leunardus Djerol

NIM. P1911142

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PASAPUA AMBON

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN

SULI

2023

SKRIPSI

GAMBARAN FAKTOR PENYEBAB KEJADIAN ISPA PADA LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PASSO

Diajukan sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep)

OLEH :

Leunardus Djerol

NIM. P191142

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PASAPUA AMBON

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN

SULI

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama	:	Leunardus Djerol
NIM	:	P.1911142
Program Studi	:	Ilmu Keperawatan
Judul	:	**GAMBARAN FAKTOR PENYEBAB KEJADIAN ISPA PADA LANSIA**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Pada Ujian Skripsi Di Hadapan Dewan Penguji

Ditetapkan di : Suli

Tanggal : 24 November 2023

Pembimbing

DWIGHT NUSAWAKAN, SH., MH

NIDN: 1220018902

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

GAMBARAN FAKTOR PENYEBAB KEJADIAN ISPA

PADA LANSIA DI WILAYAH KERJA

PUSKESMAS PASSO

Telah berhail di pertahankan pada seminar skripsi

Dan Di Terima Sebagai Bagian Persyaratan Yang Di Perlukan Untuk Memperoleh Gelar Serjana Keperawtan Pada Program Studi Ilmu Keperawatan.

Pada : Hari Jumat

Tanggal : 24 November 2023

Dewan Penguji :

1. Dwight Nusawakan, SH.,MH ( )
   (Pembimbing)
2. Sakina Makatita, S.Kep, Ns, M. Epid ( )
   (Penguji I)
3. Sarti Norfianti Elbetan,S. ST.,M.Kes ( )
   (Penguji II)

Mengetahui

Wakil ketua I bidang akademik stikes pasapua ambon	Ketua program studi ilmu keperawatan stikes pasapua ambon
Asriaty Dinopawe, S.,ST.M. kep	**Harianti Fajar, S.Kep.,Ns.,M.Kes**
NIDN : 1219018902	**NIDN. 122507900**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Leunardus Djerol

Nim : P1911142

Judul : **"GAMBARAN FAKTOR PENYEBAB KEJADIAN ISPA PADA LANSIA" DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PASSO.**

Dengan ini saya Menyatakan bahwa penulisan skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjana di perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya mengakui bahwa skripsi ini dapat dihasilkan berkat bimbing serta dukungan dari dosen pembimbing saya, yaitu Dwight Nusawakan, SH., MH. Dan apabila dikemudian hari ditemukan hal – hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ambon,24 November

Leunardus Djerol

DATA PENULIS

1. Identitas

Nama	: Leunardus Djerol
Nim	: p1911142
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat tanggal lahir	: 12 Oktoer 1992
Suku bangsa	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Anak ke	: 3 (tiga)

2. **Riwayat pendidikan**.

2004	: SD Kristen Dokatimur
2007	: Smp Negeri 1 DOBO
2012	: Sekolah perawat kesehatan
2023	: S1. Keperawatan

Alamat	: Desa Dokatimur Kabupaten kepulauan aru
Email	: leodjerol1992
Jumlah saudara	: 5 (lima)
Nama orang tua	:

1. ayah : Manuel djerol
2. yuliana : laim

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, Penulis naikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat dan pertolongannya, serta berkat dan anugerahNya sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang bejudul “GAMBARAN FAKTOR PENYEBAB KEJADIAN ISPA PADA LANSIA” di wilayah kerja puskesmas passo. Dalam Penulisan Skripsi ini, Penulis telah mencurahkan segala kemampuan dan pengetahuan yang telah didapat, namun Penulis menyadari Sesungguhnya bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, segala kritik, saran, masukan yang bertujuan penyempurnaan Skripsi ini sangat Penulis harapkan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih tersebut ditujukan kepada :

1. Swastika Santila Rudani Ake, S.Ked Selaku Ketua Yayasan Bangun Prima Persada yang telah memanfasilitasi Penulis selama mengikuti pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Ambon yang telah bersedia menyiapkan sarana dan prasarana yang nyaman selama masa perkuliahan.
2. Dewi Arwini Bugis, S.Kep., Ns.,M.Kep Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Ambon Yang Telah membina dan mengarahkan Penulis selama mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Ambon.
3. Harianti Fajar, S.Kep., Ns., M.Kes Selaku Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Ambon, yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Ambon.
4. Dwight Nusawakan, SH.,MH Selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyusun Skripsi ini sampai pada akhir penelitian.

5. Sakina Makatita, S.Kep,Ns.M. Epid selaku Penguji I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis.
6. Sarti Nofrianti Elbetan, S.ST.,M.Kes selaku Penguji II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis.
7. Seluruh Staf Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan selama Penulis mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Ambon.
8. Kepalah Puskesmas Dan Seluruh staf puskesmas passo yang sudah menerima peneliti untuk melakukan penelitian di Puskesmas Passo
9. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang telah mempercayai penulis untuk melanjutkan studi S1 Ilmu Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesahatan Pasapua Ambon
10. Kedua orang tua,dan semu keluarga yang selama ini telah mendukung serta mendoakan penulis untuk melaksanakan studi semoga Tuhan yang maha esa selalu dan senatiasa memberkati selalu.

Akhir kata Penulis berharap Skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya ilmu kesehatan.

Suli, 24 November 2023

Peneliti

Leunardus djerol

ABSTRAK

Program Studi Ilmu Keperawatan
STIKES Pasapua Ambon
Skripsi, November 2023

Leunardus Djerol (P1911142)
"Gambaran faktor penyebab kejadian ISPA pada lansia" Di wilayah kerja puskesmas passo. (Dibimbing oleh Dwight Nusawakan)
(xv + 70 halaman + 1 gambar + 5 lampiran)

Infeksi sluran pernapasan akut ISPA adalah infeki saluran pernapasan akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran nafas mulai hidung sampai alfeoli termaksut adneksanya *(World Heald Organization/WHO),*

Untuk mengetahui gambaran kadaan ventilasi yang menyebabkan ISPA pada lansia di wilayah kerja puskesmas passo.

Untuk mengetahui gambaran kebiasaan merokok yang menyebabkan ISPA pada lansia, di wilayah kerja puskesmas Passo.

Untuk mengetahui gambaran keadaan lingkungan /pekerjaan yang menyebabkan ISPA pada lansia di wilayah kerja puskesmas passo.

Untuk mengetahui gambrn pengetahuan yang menyebabkan ISPA pada lansia di wilayah kerja puskemaas passo.

Jenis penelitian yang di gunkan dalam penilitian ini yaitu penilitian kualitatif dengan mengunakan pendekatan studi kasus. Dengan sampel 5 informan. Teknik sampel Purposive adalah sampel yang di pilih beriorentasi pada tujuan penilitian.

Berdasarkan hasil penilitian yang di lakukan di puskesmas passo, tentang gambaran faktor penyebab kejadian ISPA pada lansi, terdapat beberpa vaktor yaitu: Ventilasi, kebiasaan merokok, Lingkungan/pekerjaan, pengetahuan.

Penelitian ini di lakukan dengan metode *Fenomenologi* dengan teknik pengumpulan data secara wawancara dengan *5 infoman*. Maka penulis merarik kesimpulan bahwa kesehatan sangat penting bagi maanusia.

Kata kunci*: Ventilasi, kebiasaan merokok, lingkungan/pekerjaan, pengetahuan.*

Pustaka 39 (2019-2023)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....i
HALAMAN JUDUL.....ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN.....iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI.....x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Rumusan Masalah.....1
B. Tujuan Penelitian 9
   1. Tujuan Umum 9
   2. Tujuan Khusus.....9
C. Manfaat Penelitian 9
   1. Manfaat Teoritis.....10
   2. Manfaat Aplikatif 10

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Teori Tentang Kesehatan Jiwa.....12
B. Tinjauan Teori Tentang Skizofrenia 25
C. Tinjauan Teori Tentang Kekambuhan.....35
D. Tinjauan Teori Tentang Dukungan Keluarga 39
E. Tinjauan Teori Tentang Kepatuhan Minum Obat 46
F. Tinjauan Teori Tentang Petugas Kesehatan 51

BAB III DEFINISI OPERASIONAL

A. Definisi Operasional 58

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....59
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....60
C. Populasi 60
D. Informan dan Teknik Penentuan Informan.....61
E. Instrumen Penelitian 62
F. Sumber Data.....62
G. Teknik Pengumpulan Data.....63
H. Analisa Data 65
I. Etika Penelitian 68
J. Alur Penelitian.....70

BAB V HASIL PENELITIAN

A. Hasil penelitian 71
B. Keterbatasan selama penelitian.....94

BAB VI PEMBAHASAN

A. Faktor Kepatuhan Minum obat 95
B. Faktor Dukungan Keluarga 101
C. Faktor Dukungan Petugas Kesehatan 107
D. Kepala Ruangan 114
E. Perawat 117

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan 121
B. Saran 122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 3.1 Defenisi Operasional…… 58

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 4.1 Alur Penelitian…….. 70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian
Lampiran 2 Permohonan Menjadi Informan
Lampiran 3 Persetujuan Menjadi Informan
Lampiran 4 Lembar Wawancara Penelitian
Lampiran 5 Lembar Observasi Penelitian
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari puskesmas Passo
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian
Lampiran 8 Lembar Konsultasi Penyusunan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Inpeksi saluran pernapasan merupakan penyakit saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh agen infeksius yang menimbulkan gejala dalam waktu beberapa jam sampai beberapa hari. Penyakit ini ditularkan umumnya melalui droplet, namun berkontak dengan tangan atau permukaan yang terkontaminasi juga dapat menularkan penyakit ini. Inspeksi saluran pernapasan adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas penyakit menular di dunia. Hampir empat juta orang meninggal akibat Inspeksi saluran pernapasan setiap tahunnya Selain itu, Inspeksi saluran pernapasan merupakan penyebab utama konsultasi atau rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan terutama pada bagian perawatan anak.Hal yang serupa juga terjadi di Indonesia (Maharani, 2017).

Inpeksi saluran pernafasan yang terjadi pada lansia disebabkan oleh beberapa penyebab yaitu, gizi, kurang mengkonsumsi Makanan 4 sehat 5 sempurna, kurang memperbanyak minum air putih dan kurang olahraga. Adapun komplikasi ketika penyakit Inspeksi saluran pernapasan pada lansia tidak ditangani berakibat Hipoksemia dimana nantinya klien akan mengalami penurunan nilai $PaO_2 < 55\ mmHg$, dengan nilai saturasi oksigen<85%. Pada awalnya klien akan mengalami perubahan mood, penurunan konsentrasi dan menjadi pelupa (Arudkk, 2006).

Faktor pendukung terjadinya Infeksi saluran pernapaan meliputi umur, jenis kelamin, dan pekerjaan, lingkungan. Selain itu factor tingkat

pengetahuan juga sangat mempengaruhi seorang lansia terkena Inspeksi saluran pernapasan. Semakin tinggi pengetahuan seseorang maka ia akan mengerti tentang penyakit tersebut dan berusaha untuk menghindarinya (Sumijatun, 2002)

Inpeksi saluran pernapasan di Indonesia merupakan penyebab salah satu masalah pada kesehatan yang utama.Infeksi Saluran Pernafasan Akut merupakan pernyakit terbanyak menduduki peringkat ke sepuluh, penyebab utama merupakan kejadian penyakit menular (pravelensi penyakit) dan moralitas (ukuran jumlah kematian dalam suatu populasi) penyakit menular di dunia.Sebagian besar hamper empat juta orang meninggal dengan kasus Inspeksi saluran pernapasan pada tiap tahunnya.Tingkat moralitas akibat kasus pada Inspeksi saluran pernapasan yaitu pada bayi,anak dan orang usia lanjut (Setyowati & Mariani, 2021).

World Health Organization WHO (2023). memperkirakan insiden ISPA di Negara berkembang dengan angka kematian diatas 40 per 1000 orang adalah 15-20% pertahun pada golongan lansia. WHO menyatakan sebanyak 5 juta lansia di dunia meninggal setiap tahun dan sebagian besar kematian tersebut terdapat di Negara berkembang, dimana Inspeksi saluran pernafasan merupakan salah satu penyebab utama kematian dengan membunuh sebanyak 2 juta lansia setiap tahun Asrun (2010).

Berdarkan data Inpeksi saluran pernapasan provinsi maluku dari tahun 2018-2020 penyakit tertingi adalah Inspeksi saluran pernapasan dengan jumlah 62.368 orang. Dari tahun 2019 jumlah jiwa yang mengalami ISPA berjumlah 79434 jiwa, tahun 2020 jumlah pasien yang mengalami

penyakit Inspeksi saluran pernapasan berjumlah 62.461 jiwa, Ramajanti, A 2002.

Penelitian Yusuf Milawati, 2016 dengan judul hubungan lingkungan rumah dengan kejadian infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) Pada Masyarakat Pesisir Kelurahan Lapulu diketahui bahwa terdapat hubungan pencahayaan alami, kepadatan hunian dengan kejadian ISPA.10. Pengetahuan ibu tentang ispa berhubungan dengan kemampuan ibu merawat Balita Inspeksi saluran pernapasan Pada Balita Di Puskesmas Bahu Kota Manado. Manado. 11

Hasil penelitian Oktaviani I, Hayati S, Supriatin E, 2014 dengan judul Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) diketahui bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara ventilasi dengan kejadian Inspeksi saluran pernapasan.

Hasil Penelitian (Nurul Huda, 2021) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kondsi fisik rumah dan keberadaan perokok dalam rumah dengan kejadian Inspeksi saluran pernapasan pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

Hasil penelitian WAHYU DEKAWATI 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status gizi dengan kejadian Inspeksi saluran pernapasan dan diare pada lansia di puskesmas musuk i boyolali.

Berdasarkan Hasil observasi pengambilan data awal di Puskesmas Passo, jumlah pasien lansia yang berkunjung ke puskesmas passo yang mengalami ISPA dari Tahun 2019–2022 berjumlah 7.824. Pada tahun 2019 jumlah pasien ISPA pada lansia yaitu 1.132, tahun 2020 berjumlah 1.650, tahun 2021 berjumlah 1.822, tahun 2022 berjumlah 2912. Dari tahun 2023

dari bulan januari sampai juni berjumlah 308 pasien lansia yang mengalami ISPA di wilayah kerja puskesmas passo.

Berdasarkan hasil observasi tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul" GAMBARAN FAKTOR PENYEBAB KEJADIAN ISPA PADA LANSIA di wilayah kerja puskesmas passo.

B. Permasalahan

Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini yaitu: Bagaimana gambaran Penyebab Kejadian Inspeksi saluran pernfasan pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Passo?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Di ketahui" GAMBARAN FAKTOR PENYEBAB KEJADIAN INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT PADA LANSIA di Wilayah Kerja Puskesmas Passo

2. Tujuan Khusus

a. DiKetahui gambaran keadaan Ventilasi yang menyebabkan terjadinya Inpesi saluran pernapasan pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Passo.

b. Diketahui gambaran Kebiasaan Merokok yang menyebabkan terjadinya Inspeksi saluran pernapasan pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Passo

c. Diketahui Gambaran keadaan Lingkungan Rumah/Pekerjaan yang menyebabkan terjadinya Inpeksi salurn pernapsaaan pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Passo.

d. Diketahui gambaran Pengetahuan yang menyebab kanterjadinya Inspeksi saluran pernaapasan pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Passo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitianini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi ilmiah guna mencegah dan mengurangi resiko terjadinya Inspeksi saluran pernpasan pada lansia.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Informan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi Lansia dalam menanggulangi masalah Inspeksi saluran pernapasan yang mereka alami.

b. Bagi Puskesmas

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan informasi bagi pengelola Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam melakukan penanganan Insspeksi saluran pernapasa yang dialam ioleh Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Passo.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dan referensi bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Ambon dalam penelitian selanjutnya yang membahas tentang masalah kejadian Inspeksi saluran pernapsan pada Lansia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang ISPA pada lansia

1. Defenisi ISPA

ISPA adalah Inspeksi saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah.ISPA di sebabkan oleh virus,jamur,dan bakteri. ISPA akan menyerang host apabila kekebalan tubuh atau immunologi menurun Sukarto,Riska Cahya Dkk .2016).

Menurut *WHO*,Inspeksi saluran pernapasan adalah penyakit menular dari saluran pernapasan atas atau bawah yang Infeksi Saluran Pernapasan Akut adalah radang akut saluran pernapasan atas maupun bawah yang disebabkan oleh bakteri, dan virus tanpa atau disertai dengan radang parenkim paru (Wijayaningsi, 2013).

Infeksi saluran pernapasan akut ISPA merupakan infeksi akut yang melibatkan organ dapat menimbulkan berbagai spectrum penyakit berkisar dari infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan mematikan, tergantung pada pathogen penyebabnya, faktor penjamu dan faktor lingkungan. Penyakit Inspeksi sauran pernapasan adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas penyakit menular di dunia. Penyakit Inspeksi saluran pernapasan juga penyebab utama kematian terbesar ketiga didunia dan pembunuh utama di Negara berpenghasilan rendah dan menengah.Kematian akibat penyakit Inspeksi saluran pernapasan sepuluh sampai lima puluh kali di Negara berkembang dari pada Negara maju. ISPA termasuk golongan *Air Borne Disease* yang penularan penyakitnya melalui

udara. Patogen yang masuk dan menginfeksi saluran pernafasan dan menyebabkan inflamasi Depisa, D. (2022)

ISPA adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas penyakit menular di dunia.Hampir empat juta orang meninggal akibat ISPA setiap tahunnya Selain itu, Inspeksi saluran pernapasan merupakan penyebab utama konsultasi atau rawatinap di fasilitas pelayanan kesehatan terutama pada bagian perawatan anak.Hal yang serupa juga terjadi di Indonesia Marleni, ER Lili, et al. (2022)

Infeksi saluran pernapasan akut Inspeksi saluran pernapasan merupakan infeksi akut yang melibatkan organ saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah.Inspekssi sluran pernapasan disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri. Inspeksi saluran pernapasan akan menyerang host apabila kekebalan tubuh atau imunologi menurun Narmawan, Narmawan,Yuni widya, dkk.(2020).

2. Klasifikasi

Pengelolan lansia menurut Depkes di kutip dari Nurhafika, nurhafika (2020) di kelompokan menjadi tiga kelompok yaitu :

a) Kelompok lansia dini (55-4 thun), erupakan kelompok baru memasuki lansia.
b) Kelompok lansia(63 tahun ke atas)
c) Kelompok lansia resiko tinggi. yaitu lansia yang lebih dari (70 tahn)

3. Etiologi

ISPA dapat di sebabkan oleh bakteri dan virus, yang paling sering menjadi penyebab Inspeksi saluraan pernaapasan di antara bakteri Stafilokokus dan Streptokokus serta virus Influenza yang di udara bebas akan masuk dan menempel pada saluran pernapasan bagian atas yaitu hidung dan tenggorokan. Beberapa factor lain yang di perkirakan berkontribusi terhadap kejadian ISPA pada anak adalah rendahnya asupan antioksi dan, status gizi kurang, dan buruknya sanitasi lingkungan Mujid, Muhammad zydan dkkl (2022)

4. Tanda Dan Gejala

Tanda dan gejala Inspeksi sauran pernapan banyak bervariasi antara lain

Demam, pusing, malaise (lemas), anoreksia (tidak nafsu makan), *vomitus*, (muntah), photophobia (takut cahaya), gelisah, Batuk keluar secrets tridor (suarah nafas) *dyspnea* (kesakitan bernafas) retraksi suprasternal (adanya tarikan dada) hipoksia (kurang oksigen), dan dapat berlanjut pada gagal nafas apabila tidak mendapat pertolongan dan mengakibatkan kematian Amalia, Ary Nahdiyani, dkk (2023)

5. Patofisiologi

Menurut (Amalia Nurin, dkk, (2014) Perjalanan alamiah penyakit Inspesi saluran pernapasan di bagi 4 tahap yaitu:

a. Tahap prepatogenesis: penyebab telah ada tetapi belum menunjukkan reaksi apa-apa.
b. Tahap inkubasi: virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa.

   Tubuh menjadi lemah apalagi bila keadaan gizi dan daya tahan sebelumnya rendah.
c. Tahap dini penyakit: dimulai dari munculnya gejala penyakit, timbul gejala demam dan batuk.
d. Tahap lanjut penyakit, dibagi menjadi empat yaitu dapat sembuh sempurna, sembuh dengan atelektasis, menjadi kronis dan meninggal akibat pneumonia.

6. Manifestasi klinis

Gambaran klinis secara umum yang sering di dapat adalah 12 hinitis, nyeri tenggorokan, batuk dengan dahak kuning/ putih kental, nyeri retrosternal dan konjungtivitis. Suhu badan meningkat antara 4-7 hari disertai malaise, mialgia, nyeri kepala, anoreksia, mual, muntah dan insomnia. Bila peningkatan suhu berlangsung lama biasanya menunjukkan adanya penyulit. (Suriani, 2018)

Gejala Inspeksi saluran pernapasan berdasarkan tingkat keparahan adalah sebagai berikut Rosana (2016)

a. Gejala dari Inspeksi saluran pernapasan ringan

Seseorang dinyatakan menderita Inspeksi sluran pernapasan ringan jika ditemukan satu atau lebih gejala-gejala sebagai berikut

1) Batuk.
2) Serak, yaitu anak bersuara parau pada waktu mengeluarkan suara (pada waktu berbicara atau menangis).
3) Pilek, yaitu mengeluarkan lendir atau ingus dari hidung.
4) Panas atau demam, suhu badan lebih dari 37°C atau jika dahi anak diraba dengan punggung tangan terasa panas.

7. Komplikasi

a. Meningitis

Maningitis adalah peradangan yang terjadi pada manigen, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Maningiti atau radang salah ototak yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit.

b. Pneumonia

Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang di sebabkan oleh infeksi. Pneumonia juga di kenal dengan istilah paru-paru basah. Pneumonia biasa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat.

c. Bronkitis

Bronkitis adalah iritasi atau peradangan di dinding saluran bronkus, yaitu pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru.

d. Sinusitis

Sinusitis adalah peradangan pada dinding sinus yang merupakan rongga kecil berisi udara dan terletak pada struktur tulang wajah.

e. Hipoksia akibat gangguan difusi

Hipoksia adalah kondisi kekurangan oksigen dalamsel dan jaringan tubuh, sehingga fungsi normalnya mengalami gangguan. Hipoksia merupakan kondisi berbahaya karena dapat mengganggu fungsi otak, hati, dan organ lainnya

8. Pencegahan Ispa

Pencegahan pada ispa

Menurut Naufal, Adnan Faris, et al 2023 pencegahan ISPA dapat di lakukan dengan :

a. Menyediakan makanan bergizi sesuai preferensi anak dan kemampuan untuk mengkonsumsi makanan untuk mendukung kekebalan tubuh alami
b. Pemberian imunisasi lengkap kepada anak
c. Keadaan fisik rumah yang baik, seperti: ventilasi di rumah dan kelembaban yang memenuhi syarat.
d. Menjaga kebersihan rumah, tubuh, makanan, dan lingkungan agar bebaskuman penyakit.
e. Menghindari asap rokok, asap dapur.
f. Mencegah kontak dengan penderita ISPA dan isolasi penderita ISPA untuk mencegah penyebaran penyakit.

B. Tinjauan Umum tentang Lansia

1. Pengertian Lansia

Lansia (lanjut usia) adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan. Kelompok yang di kategorikan lansia ini akan mengalami suatu proses yang di sebut *Aging Process* ata *uproses* penuan. Adriana, Mardian, dan Sri yanti. 2019

Lansia merupakan tahap akhir dari proses penuan. Proses menjadi tua akan dialami oleh setiap orang. Masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir, di mana pada masa ini seseorang akan mengalami kemunduran fisik,mental dan social secara bertahap sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sehari-hari (tahap penurunan). Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan dan sel, yang mengalami penurunan kapasitas fungsional.Pada manusia, penuaan dihubungkan dengan perubahan *degeneratif* pada kulit, tulang, jantung, pembuluh darah,paru-paru, saraf dan jaringan tubuh lainnya.Dengan

kemampuan generatif yang terbatas, mereka lebih rentan terkena berbagai penyakit,sindrom ada kesakitan di bandingkan dengan orang dewa salain (Handayani, Vivin Affrilina, dkk 2022).

Seseorang di katakan lansia apabilah suda berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan baik jasmani, maupun Rohani, maupun social. Nugroho 2012

Pada lansia akan mengalami proses hilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri secara perlahan sehingga tidak dapat mempertahankan tubuh dari infeksi dan tidak mampu memperbaiki jaringan yang rusak (Oktaviania, A,V ,V.2023)

2. Pengolonngan lansia

Penggolongan lansia. Prastika, yoland, et al (2022) di artikan menjadi tiga kelompok yakni:

a. Kelompok lansia dini (55-64 tahun), merupakan kelompok baru memasuki lansia.
b. Kelompok lansia (65 tahun ke atas)
c. Kelompok lansia resiko tinggi,yaitu lansia yang berusia lebih dari 70 tahun.

Beberapa pendapat ahli dalam Maula, A.N.M. ,2020 tentang batasan-batasan umur pada lansia sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dalam BAB 1 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas”.
b. *World Health Organization* (WHO), lansia dibagi menjadi 4 kriteria yaitu usia pertengahan (*middle ege*) dari umur 45-59 tahun, lanjut usia

(*elderly*) dari umur 60-74tahun, lanjut usia (*old*) dari umur 75-90 tahun dan usia sangat tua (*veryold*) ialah umur diatas 90 tahun.

c. (Dra.JosMas (PsikologiUI) terdapat empat fase,yaitu:fase invenstus dari umur 25-40 tahun, fasevirilities dari umur 40-55 tahun, fase prasenium dari umur 55-65 tahun dan fase senium dari 65 tahun sampai kematian

d. Prof. Dr. Koesoemato Setyonegoro masa lanjut usia (*geriatric age*) dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu

   1) *young old*dari umur 75-75 tahun
   2) *old* dari umur 75-80 tahun
   3) *veryold* 80 tahun keatas.

3. Ciri – Ciri lansia.

Menurut Depkes RI.Kristiningtyas,Y.W., dkk. 2021, ciri ciri lansia sebagai berikut :

a. Lansia merupkan periode kemunduran

   Kemunduran pada lansia sebagai datang dari faktor fisik, dan faktor fisiologis sehingga motifasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Misalnya lansia yng memiliki motivasi yang rendah dalam melakukan kegiatan, maka akan mempercepat proses kemunduran fisik, tapi akan tetapi ada lansia yang memiliki motivasi yang tinggi, maka kemunduran fisik akan lebih lama terjadi.

b. Lansia memiliki status kelompok minoritas

   Kondisi ini menjadi akibat dari sikap social yang tidak menyenangkan terhadap lansia dan di perkuat oleh pendapat yang kurang baik, misalnya lansia yang lebih senang mempertahankan pendapatnya maka sifat social di masyarakat menjadi negatif, tetapi juga lansia yang

mempunyai tengang rasa kepada orang lain sehingga sikap social masyarakat menjadi positif.

c. Menua membutuhkan peran

Perubahan peran pada lansia sebaiknya di lakukan pada keinginan sendiri, bikan atas dasar tekanan dari lingkungan. Misalnya lansia menduduki jabatan social di masyarakat sebagai ketua RW karena usianya.

d. Penyesuaian yang buruk pada lansia

Perilaku yang buruk terhadap lansia membut mereka cendrung, mengembangkan konsep diri yang buruk sehingga dapat emperlihat konsep perilaku yang buruk. Akibat dari perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaiaan diri lansia menjadi buruk pula.

4. Penyebab lansia

Kemampuan fisiologis seseorang akan mengalami penurunan secara bertahap dengan bertambahnya umur. Proses penuaan ditandai dengan kehilangan massa otot tubuh sekitar 2 – 3% dekade. Sarkopenia merupakan kehilangan massa otot yang berkaitan dengan usia yang berkontribusi terhadap penurunan kekuatan otot, perubahan pada gaya berjalan dan keseimbangan, kehilanganfungsi fisik, dan meningkatnya risiko penyakit kronis. Penyakit pada usia lanjut bersifat multi patologis atau mengenai multiorgan atau sistem, degeneratif dan saling terkait, kronis dan cenderung menyebabkan kecacatan lama sebelum terjadinya kematian, dan biasanya juga mengandung psikologis dan sosial Darmojo dan Martono, 2006.

5. Pengertian Proses Penuaan

Proses penuan adalah.Siklus kehidupan yang di tandai dengan tahap tahapan penurunan berbagai fungsi organ tubuh, yang di tandai dengan semakin rentangnya tubuh terhadap berbaga serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian misalnya pada sistem kardiofaskuler dan pembuluh darah, pernafasan, pencemaran, endokrin dan lain sebagainya. Hal tersebut di sebabkan seiring dengan peningkatan usia sehingga terjadiperubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. (Suri.D.R.2021)

6. Faktor- faktor yang mempengruhi penuaan pada lansia

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penuaan yang dapat dibagi menjadi dua bagian,yaitu :

a. faktor genetic yang melibatkan perbaikan DNA, respon terhadap stress dan pertahanan terhadap antioksida
b. factor lingkungan meliputi pemasukan kalori, berbagai macam penyakit dan stres dari luar, misalnya radiasi atau bahan-bahan kimiawi.Kedua factor tersebut akan mempengaruhi aktivitas metabolisme yang menyebabkan stressoksidasi sehingga terjadinya kerusakan sel dan terjadinya proses penuaan (Sunaryo, et. al, 2016).

Menurut Sunaryo et.al (2016) terdapat beberapa teori penuaan (*aging process*) yaitu:

1) Teori Biologis

Teori biologis berfokus pada proses fisiologi dalam kehidupan seseorang dari lahir sampai meninggal dunia,perubahan yang terjadi pada tubuh dapat dipengaruhi oleh factor luar yang bersifat patologi. Proses menua merupakan terjadinya perubahan struktur dan fungsi tubuh selama

fase kehidupan.Teori biologis lebih menekan pada perubahan struktural sela tau organ tubuh termasuk pengaruh agen patologis

2) Teori Psikologi (*PsycologicTheories Aging*)

Teori psikologi menjelaskan bagaimana seorang merespon perkembangannya.Perkembangan seseorang akan terus berjalan walaupun seseorang tersebut telah menua.Teori psikologiterdiri dari teori hierarki kebutuhan manusia maslow (*maslow's hierarchy of human needs*), yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dari tingkat yang paling rendah (kebutuhan biologis / fisiologis/sex, rasa aman,kasih sayang dan harga diri) sampai tingkat paling tinggi (aktualisasi diri). Teori individualisme (*jung'stheory of individualisme*), yaitu sifat manusia terbagi menjadi dua, yaitu *ekstrover* dan *introver*. Pada lansia akan cenderung introver,lebih suka menyendiri. Teori delapan tingkat perkembangan erikson (*erikson'seight stages of life*), yaitu tugas perkembangan terakhir yang harus dicapai seseorang adalah *egointe grityvsdisappear.* Apabila seseorang mampu mencapai tugas ini maka dia akan berkembang menjadi orang yang bijaksana (menerima dirinya apa adanya, merasa hidup penuh arti,menjadi lansia yang bertanggung jawab dan kehidupannya berhasil).

3) Teori Kultural

Teori cultural di kemukakan oleh Blakemore dan Boneham menjelaskan bahwa tempat kelahiran seseorang berpengaruh pada budaya yang dianutnya.Budaya merupakan sikap,perasaan,nilai dan kepercayaan yang terdapat pada suatu daerah dan dianut oleh kaum

orang tua.Budaya yang dimiliki sejak ialahir akan selalu di pertahankan sampai tua.

4) Teori Sosial

Teori social dikemukakan oleh Lemon yang meliputi teori aktivitas lansia yang aktif dan memiliki banyak kegiatan sosial, teori pembebasan (perubahan usia seseorang mengakibatkan seseorang menarik diri dari kehidupan sosialnya) dan teori kesinambungan (adanya kesinambungan pada siklus kehidupan lansia, lansia tidak diperbolehkan meninggalkan peran dalam proses penuaan).

5) Teori Genetika

Teori genetika dikemukakan oleh Hayflick bahwa proses penuaan memiliki komponen genetilk. Dilihat dari pengamatan bahwa anggota keluarga yang cenderung hidup pada umur yang sama dan mereka mempunyai umur yang rata-rata sama,tanpa mengikuti sertakan meninggal akibat kecelakaan atau penyakit.

6) Teori Rusaknya Sistem Imun Tubuh

Mutasi yang berulang-ulang mengakibatkan sistem imun untuk mengenali dirinya berkurang sehingga terjadinya kelainan pada sel, perubahan ini disebut peristiwa autoimun.

7) Teori Menua Akibat Metabolisme

Pada zaman dahulu disebut lansia adalah seseorang yang botak, kebingungan, pendengaran yang menurun atau disebutdengan “budeg” bungkuk, dan beser atau inkontinensia urin.

8) Teori Kejiwaan Sosial

Teori kejiwaan sosial meliputi *activity theory* yang menyatakan bahwa lansia adalah orang yang aktif dan memiliki banyak kegitan social.*Continuity theory* adalah perubahan yang terjadi pada lansia dipengaruhi oleh tipe personality yang dimilikinya, dan *di sengagement theory* adalah akibat bertambahnya usia seseorang mereka mulai menarik diri dari pergaulan.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN ISPA PADA LANSIA

1. Faktor penyebab ispa pada lansia meliputi :

a. Umur dan jenis kelamin

Martinus Ruku (2014). Yang menyatakan umumnya inspeksi saluran pernapasan pada lansia terjadi pada laki-laki di bandingkan wanita yang di pengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti kebiasaan merokok,dan lingkungan juga dapat mempengarhi kesehatan seseorang.

b. Pekerjaan

Martinus Ruku (2014), Seorang yang memiliki pekerjaan maka akan merasa sangat menganggu setelah keadaan fisiknya tidak baik. Setelah seseorng usianya semakin tua terutama seseorang yang mempunyai pekerjaan selaku pedagang, petani, yang memerlukan kegiatan primer dan dapat menimbulkan kecemasan tersendiri.

c. Pengetahuan susantoh R & Pahroni,R. (2010). Mengatkan semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin mudah menerima informasi sehingga semakin banyak pulah pengetahuan yang di miliki, dan semakin bertambah umur,tingkat kemetangan seseorang akan lebih matng dalam berpikir, bekerja,serts memperoleh banyak pengetahuan.

d. Lingkungan dan pekerjaan rumah (sumijatun 2002). Perilaku memelihara lingkungan seperti hidup bersih, perilaku seseorang terhadap perilaku kesehatan di mana respon terhadap lingkungan sebagai penentu kesehatan manusia.

Ada beberapa faktor juga yang menyebabkab Inspeki saluran pernapasan pada lansia menurut para ahli meliputi :

1. Ventilasi

Rumah yang luas ventilasinya tidak memenuhi syarat kesehatan akan mempengaruhi kesehatan Dan penghuni rumah, hal ini disebabkan karena proses pertukaran aliran udara dari luar ke dalam rumah tidak lancar, sehingga bakteri penyebab penyakit ISPA yang ada di dalam rumah tidak dapat keluar. Ventilasi juga menyebabkan peningkatan kelembaban ruangan karena terjadinya proses penguapan cairan dari kulit, oleh karena itu kelembaban ruangan yang tinggi akan menjadi media yang baik untuk perkembang biakan bakteri penyebab penyakit Inspeksi saluran pernapasan. (Agusriyani. W.O.N. dkk 2019).

a. Standar Ventilasi Alami di Indonesia

SIDOMUKTI, P, K, U, T, D. (2013) Stanar luas venlasi alami lebih dari 120 % luas lantai tempat kerja.pengunaan ventilasi alami tidak efektif jika di gunakn dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas,deb dan pavours di temat kerja.hal ini di sebabkan tingkat kesulitan yang tinggi pada ventilai alami terkait penentuan prameter yang harus kita ketahui menyangkut kecepatan angin.tekanan angin dari luar,arah angin radiasi pnas dan beberapa besar pengaruh lubang-lubang yang ada pada dinding dan atap,ventilasi alami biasanya di gunakan dengan tujuan untuk

memberikan kesegaran dan kenyamanan pada tempat kerja yang tidak memiliki sumber bahaya yang tinggi.

b. Fungsi, Prinsip dan Mekasnisme Sistem Kerja Ventilasi adalah

mengerakan udara kotor dalam rumah atau di tempat kerja, kemudian di gantikan dengan udarah bersih. Sistem ventilasi menjadi fasilitas penting dalam upaya penyehatan dara pada suatu lingkungan kerja. ILO (1991). Ventilasi di gunakan untuk memberikan kondisi dingin, panas serta kelembaban di tempat kerja dan di dalam rumah.agar rumah selalu terhindar dari beberapa faktor seperti debuh,asap roko dan lain-lain.

2. Perilaku Merokok

Perilaku merokok adalah perilaku yang dinilai sangat merugikan dilihat dari berbagai sudut pandang baik bagi diri sendiri maupun orang lain yang ada disekitarnya (Fikriyah,S., Dan Subrijanto, Y(2012).

Perilaku merokok merupakan perilaku yang membakar salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotina tabacum, nicotina rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan dengan atau tanpa bahan tambahan Alamyah, A, dan Nopianto, N. (2017).

a. Tipe Perilaku Merokok

Ada empat tipe perilaku merokok berdasarkan *Management of Affect theory*. Keempat tipe tersebut adalah : Junisa, Nurfita Ainaiyah (2023)

1) Perilaku merokok yang dipengaruhi oleh perasaan positif

Dengan merokok seseorang mengalami peningkatan kenikmatan yang sudah diperoleh, misalnya merokok setelah minum kopi atau makan.

Perilaku merokok dilakukan sekedarnya hanya untuk menyenangkan perasaan.

2) Perilaku merokok yang dipengaruhi oleh perasaan negatif.

Banyak orang yang merokok hanya untuk mengurangi perasaan yang negatif, misalnya sesaat setelah marah, cemas dan gelisah.Rokok dianggap sebagai penyelamat, merokok bila perasaan sedang tidak enak dialami sehingga mereka terhindar dari dari perasaan yang lebih tidak mengenakan.

3) Perilaku merokok yang adiktif.

Orang-orang yang menunjukan perilaku seperti itu akan menambah dosis rokok yang digunakan setiap saat setelah efek dari rokok yang dihisapnya berkurang. Pada umumnya, mereka akan keluar rumah membeli rokok walaupun tengah malam. Sebab, mereka khawatir jika rokok tidak tersedia karena mereka sangat mengingkannya.

4) Perilaku merokok yang sudah jadi kebiasaan.

Seseorang merokok bukan demi mengendalikan perasaannya, tetapi karena benar-benar menjadi kebiasaan rutin.Baginya, merokok suatu perilaku yang bersifat otomatis sehingga sering kali dilakukan tanpa dipikirkan dan disadari.Ia menyalakan api rokoknya bila rokok yang terdahula telah benar-benar habis

b. Pengaruh Rokok terhadap Kesehatan

1) Lingkungan

Menurut Muammar, S .'(2023) menyatakan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya, kesejahteraannya dengan makhluk hidup lain baik

secara langsung maupun tidak langsung. Pada abad ke-21 ini merupakan restorasi lingkungan yang didasari oleh cinta pada bumi dan segenap kehidupan di dalamnya.Gencarnya pembangunan berbasis industri disegala sektor telah menggantikan lahan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan dan kelestarian lingkungan (Ramdhani, 2016).

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yang merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Akan tetapi, saat ini masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang terjadi secara alami, karena manusia juga menjadi faktor penyebab yang sangat signifikan terhadap kerusakan lingkungan (Herlina, 2015).

Awatara, (2011), menyatakan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini bersumber dari kesalahan perilaku manusia terhadap cara pandang dan kesalahan eksplorasi sumber daya alam.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sudarmadi et al., (2001), bahwa salah satu penyebab kerusakan lingkungan karena didominasi oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Masalah lingkungan hidup yang terjadi dapat dikatakan sebagai masalah moral, yang berhubungan dengan perilaku manusia yang akan menentukan baik buruknya kondisi suatu lingkungan (Palupi, 2017).

Kebiasaan perilaku atau tindakan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahanperubahan lingkungan hidup (Laurens, 2012).

Faktor yang mempengaruhi masalah lingkungan salah satunya ialah laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat serta dengan

adanyapembangunan dan industrial yang dijadikan sebagai solusi untuk kebutuhan hidup manusia yang memberikan dampak negatif, yaitu terjadi pencemaran lingkungan hidup yang terjadi secara berantai (Zulfa, 2016).

Hal yang paling penting dari kesadaran lingkungan setiap individu adalah pengetahuan lingkungan, nilai-nilai, kesediaan untuk bertindak dan perilaku aktual yang dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk elemen niat dan situasi (Zsóka et al., 2013).

Kesadaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan keberlanjutan perilaku atau praktik dan berfokus pada pengetahuan tentang masalah lingkungan yang terjadi secara global serta strategi untuk mengatasi masalah lingkungan (Gómez et al., 2015).

Pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong perilaku peduli lingkungan, karena bertujuan untuk meningkatkan seseorang dalam bertanggung jawab, memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang akan berkontribusi pada dunia yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Zsóka et al., 2013).

Lozano et al., (2011), menyatakan bahwa seseorang yang berpendidikan tinggi lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih termotivasi untuk terlibat dalam lingkungan yang bertanggung jawab perilaku karena mereka lebih menyadari potensi kerusakan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Julina, (2016), bahwa seiring dengan meningkatnya tentang pengetahuan, akan berdampak pada sikap dan karena karena pengetahuan, sikap dan perilaku saling berhubungan.

c. Pengaruh lingkngan terhadap kesehatan

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami,yang merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Akan tetapi,saat ini masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang terjadi secara alami,karena manusia juga menjadi factor penyebab yang sangat signifikan terhadap kerusakan lingkungan (Herlina,2015)). Awatara, (2011), menyatakan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini bersumber dari kesalahan perilaku manusia terhadap cara pandang dan kesalahan eksplorasi sumber daya alam. Hal ini sesuai dengan yang di nyatakan oleh Sudarmadi etal.,(2001),bahwa salah satu penyebab kerusakan lingkungan karena di dominasi oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.Masalah lingkungan hidup yang terjadi dapat dikatakan sebagai masalah moral, yang berhubungan dengan perilaku manusia yang akan menentukan baik buruknya kondisi suatu lingkungan (Palupi,2017).).Kebiasaan perilaku atau tindakan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan-perubahan lingkungan hidup (Laurens,2012).

Faktor yang mempengaruhi masalah lingkungan salah satunya ialah laju ISPA yang melibatkan kerusakan lingkungan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat serta dengan adanya pembangunan dan industrial yang dijadikan sebagai solusi untuk kebutuhan hidup manusia yang memberikan dampak negatif,yaitu terjadi pencemaran lingkungan hidup yang terjadi secara berantai (Zulfa,2016).

d. Soemarwoto (2007) menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan atau degradasi lingkungan merupakan tanda-tanda telah dilampauinya daya dukung lingkungan. Menurut Budiyanto, (2003). Bentuk kerusakan lingkungan hidup diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Kerusakan Hutan

   Kerusakan hutan diakibatkan oleh kegiatan manusia seperti pemanfaatan sumber daya hutan secara berlebihan, penyempitan hutan, penebangan hutan dan pengalih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman atau kegiatan pertambangan

2) Pencemaran

   pencemaran polusi adalah berubahnya keadaan alam karena unsur-unsur baru atau meningkatnya unsur-unsur tertentu sehingga menimbulkan gangguan terhadap kualitas lingkungan hidup

3) Pencemaran udara

   Pencemaran udara adalah terganggunya unsur-unsur udara karena polutan yang bersumber dari asap industri, pesawat terbang, kendaraan bermotor, bau sampah, pembaaran sampah, kebakaran hutan, dll.

4) Pencemaran air

   Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal. Pencemaran lingkungan meliputi kualitas air sumur, air sungai, danau dan air laut.

5) Pencemaran tanah

   Pencemaran tanah dapat terjadi karena kontaminasi cairan kimia berbahaya, pemakaian detergen, debu-debu radio aktif dan buangan

industry lainnyatertutupnya daerah resapan air, dan juga rusaknya hutan bakau. rendah. Longsoran merupakan hal umum terjadi sejak bumi ada.

3. Pengetahuan

a. Definisi Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya (Notoatmodjo,2010).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal.Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (over behaviour).

Menurut teori *WHO (World Health Organization*) yang dikutip oleh Notoatmodjo (2010), salah satu bentuk objek kesehatan dapat dijabarkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sendiri.

Menurut Notoatmodjo (2010) pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru di dalam diri seseorang terjadi proses yang berurutan), yakni :

1) *Awareness* (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek).
2) *Interest* (merasa tertarik), terhadap stimulus atau objek tersebut. Disini sikap subjek sudah mulai timbul.
3) *Evaluation* (menimbang-menimbang), terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya.

4) *Trial*, sikap dimana subyek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus.

5) *Adaption,* dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini, dimana didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng *(longlasting)*. Sebaliknya, apabila perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran akan tidak berlangsung lama. Jadi, Pentingnya pengetahuan disini adalah dapat menjadi dasar dalam merubah perilaku sehingga perilaku itu langgeng.

b. Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2010) jenis jenis tingkatan pengetahuan, yaitu :

1. Tahu *(know)*

   Tahu dapat diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk juga mengingat kembali suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang di pelajari atau rangsangan yang telah di terima dengan cara menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, dan sebagainya.

2. Memahami *(Comprehention)*

   Memahami di artikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dpat menginterprestasikan materi tersebut secara benar.

3. Aplikasi *(Application)*

   Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi sebenarnya.Aplikasi dapat di artikan sebagai penggunaan hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya.

4. Analisis *(Analysis)*

   Analisis merupakan suatu kemampuan untuk menjabarkan suatu materi kedalam komponen – komponen, tetapi masih didalam struktur organisasi tersebut yang masih ada kaitannya antara satu dengan yang lain dapat ditunjukan dengan menggambarkan, membedakan, mengelompokkan, dan sebagainya.

5. Sintesis *(Synthesis)*

   Sintesis merupakan suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian – bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru dengan dapat menyusun formulasi yang baru.

6. Evaluasi *(Evaluation)*

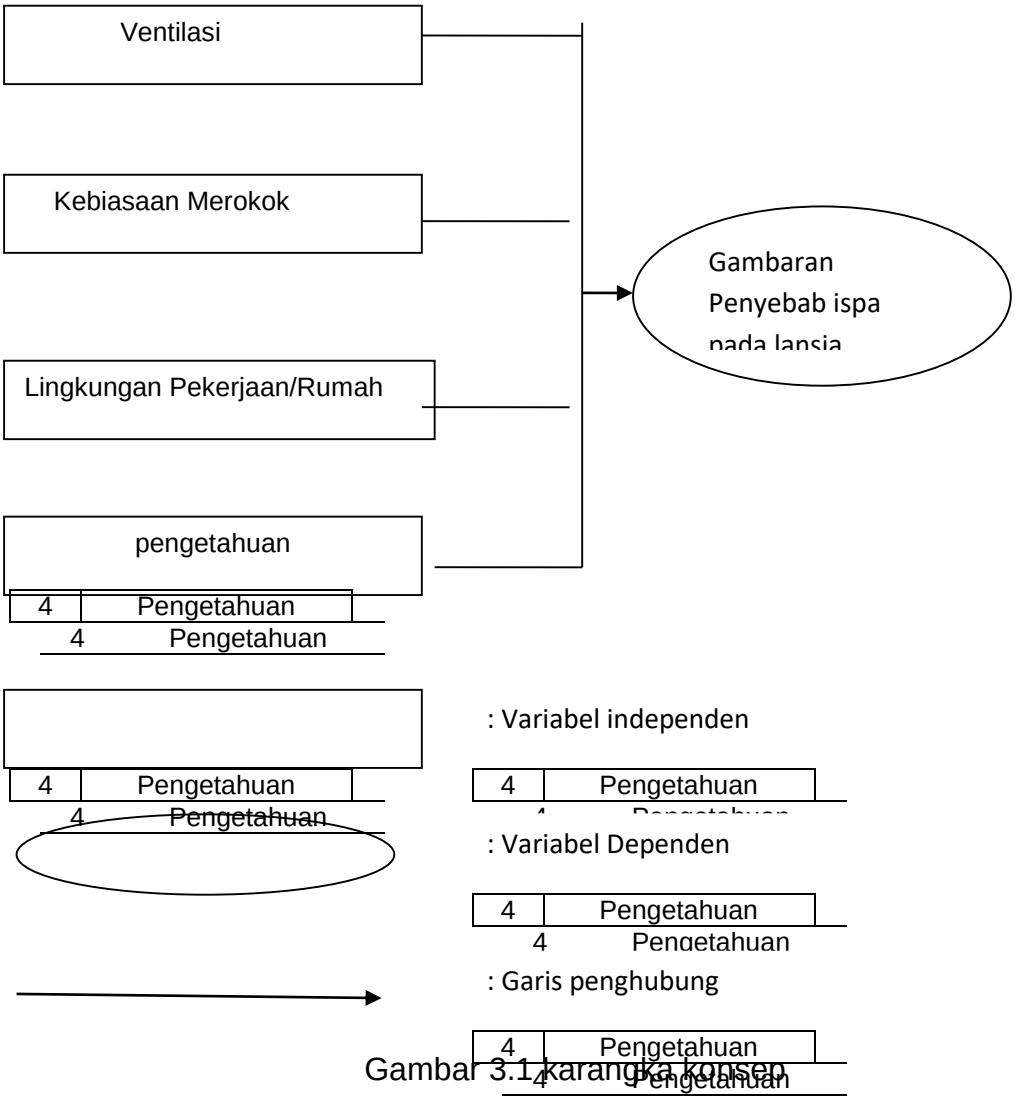
   Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi penelitian didasarkan pada suatu kriteria yang di tentukan sendiri atau kriteria yang sudah ada.

BAB III

KARANGKA KONSEP, HIPOTESIS, DAN DEFINISI OPRASIONAL

A. Karangka konsep

Karangka kosnep penelitian pada dasarnya adalah karangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin di amati atau di ukur melalui penelitian penelitian yang akan di lakukan (Notoadmojo, 2005)



Gambar 3.1 karangka konsep

B. Definisi Oprasional Variabel

Menurut Sugiyono (2019) Definisi Oprasional Variabel adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus di amati dan mengukur suatu Variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan. Oleh karena itu, untuk memberikan kemudahan dalam proses pengukuran Variabel penelitian ini, Variabel yang di bahas didefinisikan secara Oprasional sebagai berikut :

Tabel 3.1 Definisi Operasional

No	Variabel Penelitian	Definisi Oprasional	Instrumen Pengumpulan Data
1	Ventilasi	Lubang sirkulasi udara yang berada pada Rumah Lansia yang berada di Wilayah Kerja Puskesmas Passo yang memengaruhi keadaan mereka sehingga mengalami ISPA	Pedoman Wawancara
2	Kebiasaan Merokok	Kegiatan Menghisap rokok oleh Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Passo yang menyebabkan Lansia tersebut mengalami ISPA	Pedoman Wawancara
3	Lingkungan Pekerjaan/Rumah	Keadaan bersosialisasi dari Lansia yang berada di Wilayah Kerja Puskesmas Passo yang menyebabkan sehingga Lansia tersebut mengalami ISPA	Pedoman Wawancara
4	Pengetahuan	Pemahaman Lansia yang berada di Wilayah Kerja Puskesmas Passo yang memengaruhi persepsi mereka sehingga mengalami ISPA	Pedoman Wawancara

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus.

Menurut Sugiyono (2018) Metode Penelitian Kualitatif di sebut sebagai Metode Penelitian Naturalistik, karenaPenelitiannya di lakukan pada kondisi yang alami. Metode Penelitian Kualitatif adalah Metode Penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana penelitin sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara gabungan, analisis data bersifat Induktif, dan hasil Penelitian Kualitatif lebih menekankan makna. Dalam Penelitian Kualitatif, penelitian dalah Instrumen.Untuk dapat menjadi Instrumen maka Peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkostruksi obyek yang di teliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Penelitian dengan pendekatan Studi Kasus adalahKasus yang di pelajari merupakan kasus umum yang terjadi saat ini, dengan batasan waktu dan tempat terjadinya kasus tersebut untuk mengilustrasikan dan menggeneralisasikannya (Yati Afriyanti & Imami Nur Rachmawati, 2014).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan di Rumah dari Lansia yang Menderita inspeksi saluran pernapasan di Wilayah Kerja Puskesmas Passo.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan pada bulan November tahun 2023.

3. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah 308 Lansia yang Mengalami ISPA di Wilayah Kerja Puskesmas Passo

C. Informan danTeknikPenentuan Informan

1. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang Lansia yang sedang mengalami ISPA di Wilayah Kerja Puskesmas Passo. Ukuran untuk sampel dalam Pendekatan Studi Kasus adalah 4 sampai 5 Partisipan untuk Studi dalam Kasus Tunggal (Yati Afriyanti & Imami Nur Rachmawati, 2014).

2. **Teknik Penentuan Informan**

Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik Sampel Purposive.Sampel Purposive adalah sampel yang dipilih berorientasi pada tujuan penelitian.Individu di seleksi atau di pilih secara sengaja karena memiliki pengalaman yang sesuai dengan fenomena yang di teliti (Yati Afriyanti & Imami Nur Rachmawati, 2014).

3. **Instrument Penelitian**

Instrumen yang di gunakan dalam Penelitian ini yaitu Lembar Wawancara.Pertanyaan dalam Lembar Wawancara di susun berdasarkan Variabel.

Pertanyaan yang ada pada Lembar Wawancara di susun berdasarkan penjelasan Variabel yang pada BAB II.Pertanyaan yang ada pada Lembar Wawancara telah di periksa keabsahannya oleh Pembimbing Proposal.

Lembar Wawancara yang di gunakan memiliki sifat semi-terstruktur, dalam artian bahwa jika ada jawaban dari Informan yang di anggap oleh Peneliti bahwa jawaban tersebut bisa memunculkan pertanyaan baru, maka pertanyaan baru bisa di sampaikan kepada Informasi walaupun tidak ada dalam Lembar Wawancara.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari nara sumber yang berupa

a. Data primer

1. wawancara,

pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi terhadap suatu objek, kejadian atau peristiwa dan hasil pengajuan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Artinya sumber data penelitian di peroleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, jurnal penelitian, laporan tahunan yang

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti akan berkunjung ke Puskesmas Passo, kemudian Peneliti akan berkoordinasi denganTenaga Kesehatan yang sedang bertugas untuk meminta data dari Lansia yang sedang mengalami ISPA yang keadaanya memungkinkan untuk di jadikan sebagai calon Informan.

6. Wawancara

Setelah Peneliti melakukan Observasi untuk mengetahui lokasi tempat tinggal dari Lansia yang mengalami ISPA yang memungkinkan untuk di wawancarai, Peneliti akan berkunjung ke rumah para Lansia tersebut dan akan menjelaskan maksud kedatangan Peneliti kepada Keluaraga dari Lansia tersebut, kemudian setelah calon Informan memahami maksud kedatangan Peneliti,Peneliti akan memberikan Surat Permohonan Menjadi Informan dan menjelaskan maksud serta tujuan Penelitian ini, kemudian setelah calon informan memahami maksud dan tujuan yang di sampaikan oleh Peneliti, Peneliti akan memberikan Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Informan untuk di tandatangani oleh calon Informan tersebut.

Pertanyaan dalam lembar Wawancara tersebut merupakan pertanyaan dalam bentuk semi-terstruktur

yaituPertanyaan yang telah di susun berdasarkan penjelasan pada teori yang biasa mendeskripsikan substansi Penelitian namun bias muncul pertanyaan barujika dirasakan oleh Peneliti bahwa jawaban dari Informan biasa memunculkan pertanyaan baru di luar lembar Wawancara namun pertanyaan tersebut adakaitannya dengan substansi Penelitian.

Dalam melakukan Wawancara, Peneliti akan merekam percakapan yang di lakukan oleh Peneliti dan Informan dengan menggunakan aplikasi Perekam yang merupakan aplikasi original dari gadget Peneliti dan juga Peneliti akan menggunakan aplikasi Instant Transkrip yang di unduh lewat Google Play Store pada gadget Peneliti.

7. Dokumentasi

Peneliti akan mengambil gambar keadaan lokasi penelitian di mana terdapat informan yang bertujuan untuk menampilkan keadaan langsung Informan pada saat Peneliti melakukan wawancara.

8. .Analisa Data

Reduksi Data. (Data Reduction)

Peneliti akan merangkum hasil wawancara yang di lakukan terhadapInforman, kemudian hasil wawancara tersebut akan di ketik maupun di transkrip dari Aplikasi Transkripsi Instan maupun Perekam kedalam *Microsoft Office Word*.

Kemudian Peneliti akan membuat Kode (*Coding)* untuk memisahkan jawaban yang sama dari beberapa informan terhadap pertanyaan yang di sampaikan. Setelah itu, Peneliti akan mencaritema dan menentukan pola yang pada akhirnya akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudahPeneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya atau data penunjang hasil Wawancara. Dalam mereduksi data, peneliti akan memfokuskan penyusunan kesimpulan berdasarkan topic Penelitian yang sudah di tetapkan sebelumnya.

9. Penyajian Data (*Data Display*).

Setelah Peneliti mereduksi data, makala selanjutnya adalah menyajikan data.DalamPenyajian Data, Peneliti akan mengaitkan

hasil Wawancara terhadap Informan yang telah di berikan Kode (Coding) dan menentukan tema denganTeori maupun Hasil PenelitianTerdahulu yang biasa menjelaskan hasil Wawancara yang telah di reduksi.

10. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuanbaru yang sebelumnya belum pernah ada.Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatuobjek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah di teliti menjadi jelas.

11. EtikaPenelitian

Menurut Notoatmodjo (2012), etika penelitian adalah suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian yang melibatkan antara pihak peneliti, pihak yang diteliti (subjek penelitian) dan masyarakat yang akan memperoleh dampak hasil penelitian tersebut. Masalah etika yang harus di perhatikan antara lain adalah sebagai berikut :

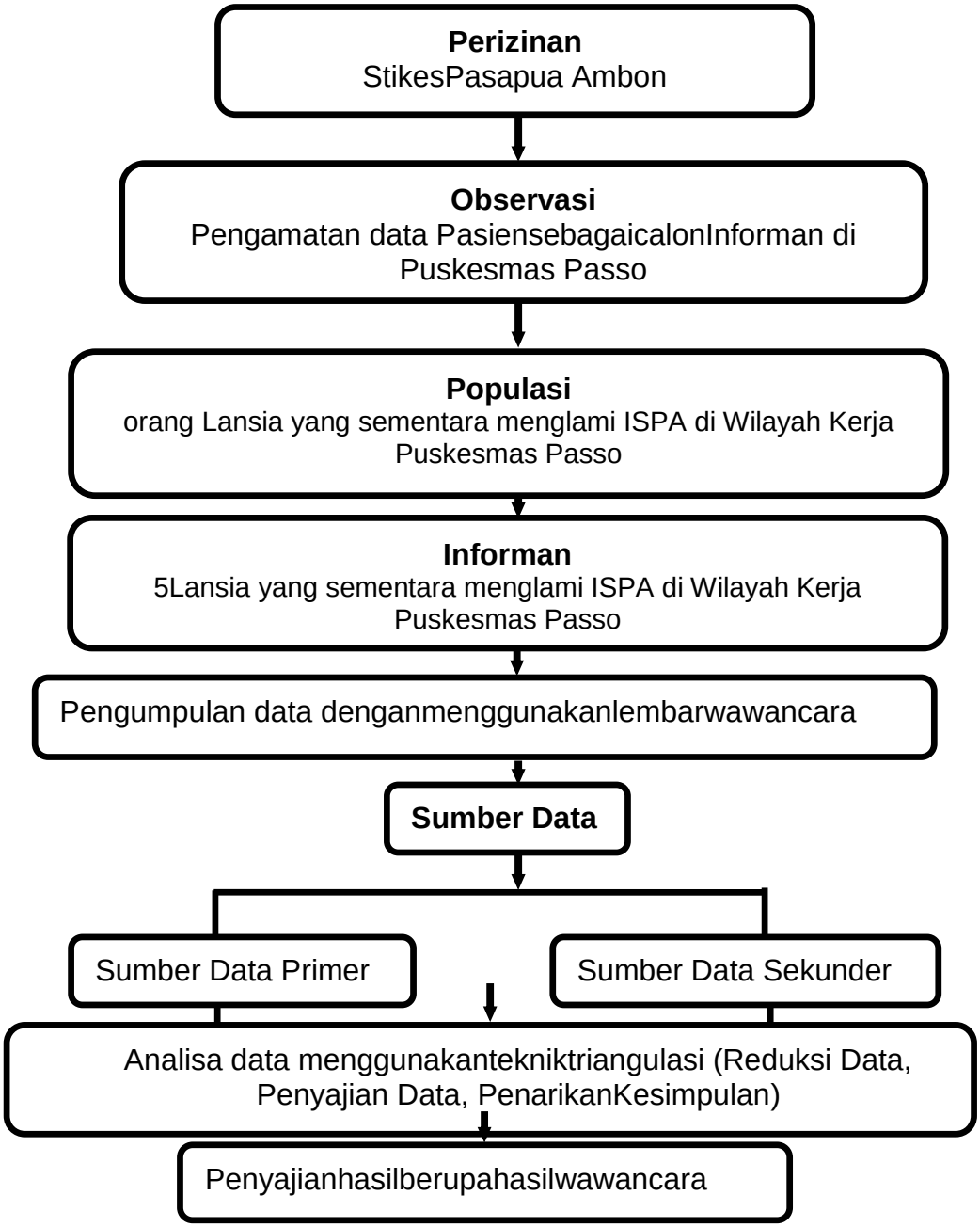
Menghormati harkat dan martabat manusia *(respect for human dignity*) Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak responden penelitian untuk mendapatkan informasi tentang tujuan peneliti melakukan penelitian tersebut, dan peneliti juga mempersiapkan lembar formulir persetujuan *(informed concent*) kepada responden.

Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*) Setiap responden mempunyai hak-hak dasari individu termasuk privasi dan kebebasan individu dalam memberikan informasi, maka dari itu seorang penelititi boleh menampilkan informasi mengenai identitas dan kerahasiaan identitas responden.

Keadilan dan inklusivitas / keterbukaan (*respect for justice an inclusiveness*) Prinsip keterbukaan dan adil perlu dijaga oleh peneliti dengan kejujuran, keterbukaan, dan kehati-hatian. Untuk itu, lingkungan penelitian perlu dikondisikan sehingga memenuhi prinsip keterbukaan, yakni dengan menjelaskan prosedur penelitian.Memperhitungkanmanfaatdankerugian yang ditimbulkan(balancing harms and benefits) Sebuah penelitian hendaknya memperoleh manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat pada umumnya, dan subjek penelitian pada khususnya. Peneliti hendaknya berusaha meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subjek (Notoatmodjo, 2012).

J. AlurPenelitian

Gambar 4.1
AlurPenelitian



BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di wilayah kerja puskemas passo tentang Gambaran faktor penyebab ISPA pada lansia. Terdapat beberapa faktor yang perlu di bahas yaitu :

a. Ventilasi
b. Kebiasaan merokok
c. Lingkungaan / pekerjaan
d. Pengetahuan

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan 5 *infoman* lansia yang bersedia untuk diwawancarai. Dan bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dapat di berikan kepada *informan* yaitu :

a. Ventilasi

P: *Apakah di rumah ada ventilasi ?*

Informan 1: yah ada.

Informan 2: ada

Informan 3: ada

Infoman 4: ada

*Informan 5 :*ada kk.

P:.Berapa ukuran ventilasi tersebut? Jelaskan

Informan 1: yah klo yang kaya gini sekitar 20 cm ya

Informan 2: kalo itu beta kurang tau,tapi sekitar 25 cm begitu kah?

Informan 3: beta kurang tau juga.ini sekitar berapa cm ini.

Infoman 4: kalo ukuran ventilasi beta sengtau bapa Tanya orang yang punya rumah boleh ini hanya beta tinggal mana mugkin katong mau tau akang pu ventilasi akang berapa.

Informan 5: kalo ventilasi ini hari itu dong biking berapa cm,beta kurang tau

P: Berapa banyak ventilasi yang di gunakan ?. jelaskan

Informan 1: ada 5 ventilasi si?

*Informan 2:*ada 7.di dalam kamar ada 3 di depan ada 4

Informan 3: ada lebih dari 20 ventilasih

Infoman 4: ada 7. Yang 3 di dalam, 4 di luar

Informan 5: ada 5 ventilasi saja kaka rumah kecil bagini, kenapa mau biking banyak-banyak.kamar 2 di depan 2 yang satu di belakang

P: Apakah ventilasih tersebut memakai penangkal debu? Jelaskan

Informan 1: nga pake itu penangkal debu.

Informan 2: seng pake

Informan 3: ventilasi sebanyak ini zgada yang pake barang itu

Infoman 4: seng pake lae

Informan 5: ventilasi begini sudah.kalo yang di kamar itu dong ada pake jaring

Jaring yang kecil lah pele nyamuk.

P:apakah Ventilasih ada debuh ? Jelaskan

Informan 1: ngga ada, selalu di bersiin terus,Setiap sapu di bersiin, soalnya debuh juga bahaya,pokonya kalo ini jendela di lap semua nga di biarin

Informan 2: pastinya ada barang ktong seng perna kasih bersih akang

Informan 3: seng lai oh. Sapa mau kasih bersih akang lae, mangkali barang 2 Kah 3 kah, tapi banyak ini, baru katong sendiri yang kera lae,biasa Kalo mau natal baru kasih bersih akang

Informan 4: itu pasti ada debuh

Infoman 5: pasti ada bu. Jarang par kasi bersih lae jdi.

P: berapa orang dalam satu kamar tidor? Jelaskan

Informan 1: saya sendiri tidor ko.satu kamar

Informan 2: beta sama anak laki-laki saja

Informan 3: katong tiga tidor satu kamar.

Infoman 4: beta tidor di belakng, tidor sendiri

Informan 5: beta deng maitua saja tidor 1 kamar.anak su besar jadi tidor sendiri Di dalam rumah ini ada 2 kelurga.jadi anak2 tidor di depan.

P: Berapa ukuran kamar tersebut? Jelaskan

Informan 1: ada 3x3 mungkin ya.

Informan 2: ada 3x3 mungkin ini.

Informan 3: sengtau ukuran

Infoman 4: 3x3 ini

Informan 5. Beta sengtau.

b. Kebiasaan merokok

P: apakah bapak / ibu merokok? Jelaskan

Informan 1: saya tidak merokok ko?

Informan 2. seng merokok, seng ada guna kalo merokok

Informan 3. seng merokok.

Infoman 4. beta isap roko tapi jarang.

Informan 5 beta seng isap roko. Beta hanya makan siri saja.

P: apakah di dalam rumah ada yang merokok? Jelaskan

Informan 1: tidak ada ko ? yang merokok

Informan 2: beta pu anak yang tua, memang dia merokok.

Informan 3: seng ada yang isap roko karna Cuma katong 3 saja

Infoman 4: beta isap roko deng ade laki l-aki yang baju kaus puti tadi, dia Polisi. Katong 2 isap roko

Informan 5 : kalo keluarga di sebelah itu, dia pu laki isap roko

P: dalam 1 minggu berapa bungkus yang di habiskan?.

Informan 1 : Nga ada ko?, Nga ada yang merokok ko?

Informan 2:. Beta juga sengtau sampai di situ. Itu urusan dia

Informan 3.: Seng ada

Infoman 4:. Satu minggu satu bungkus, hitung mi? sebelum makan satu batang, habis makan satu batang. Satu minggu hitung mi?

Informan 5 : kalo itu beta sengtau. Tanya di dia bole.

P: dalam 1 hari berapa batang roko di habiskan? Jelaskan

Informan 1 : seng ada

Informan 2 : seng ada

Informan 3 : seng ada

Infoman 4 : dua batang saja. Hanya sore deng malam saja

Informan 5 : beta seng tau kk.

c. Lingkungaan / pekerjaan

P: apakah saat keluar rumah selalu mengunakan masker? Jelaskan

Informan 1 : iya selalu saya pake masker

Informan 2 : seng pake

Informan 3 : seng pake

Infoman 4 : seng, kalo seng babatu seng pake masker to. Kalo babatu ini pake, kalo ke puskesmas, ke pengadaian, bayar bpjs, itu beta pake masker.kalo di rumah saja seng pake lae.

Informan 5: skali-skali baru beta pake. Beta seng bisa pake masker talalu lama. Nanti sesak nafas

P: apakah jika bapak/ ibu bersing selalu menutup hidung dengan tisu atau lenso? Jelaskan

Informan 1 : kalo saya selalu memakai masker

Informan 2 : biasanya beta pake lenso ini suda

Informan 3 : seng ada

Infoman 4 : Seng pake.

Informan 5 : seng lae.hantam bagitu saja

P: apakah jenis lantai rumah bapak/ibu terbuat dari permanen? Jelaskan

Informan 1: iya rumah saya permanen sih?

Informan 2: stenga permanen kh? Kalo rumah begini

Informan 3: rumah parmenen

Infoman 4: iya rumah bagi to

Informan 5: seng. Ini rumah papan saja. Dasar saja yang ada flur itu.

P: apakah dinding rumah terbuat dari bahan permanen? Jelaskan

Informan 1 : iya rumah saya itu permanen.rumah beton kan.

Informan 2 : rumah ini sudah setengah papan.

Informan 3 : ya rumah ini sudah rumah permanen

Infoman 4 : iyah

Informan 5 : dari papan saja kk

P: apakah bahan bakar di dapur menghasilkan asap? Jelaskan.

Informan 1: tidak, kita masak pake konfor aja. Kalo tungkunya pake tapi untuk rebusaan air mandi aja, tungkunya jarak ko dari rumah.

Informan 2: seng ada. Seng pake tungku

Informan 3: seng ada asap, barang katong masak pake konfor, tungku itu kalo ada ikan baru pake bakar- bakar

Infoman 4 : seng ada, barang dong pake konfor saja.

Informan 5 : iya barang dong masak pake konfor, tapi kalo minyak kering lah

dong hantam deng tungku di belakang itu.

P: *apakah lokasi rumah dekat dengan jalan rayah? Jelaskan*

Informan 1: jau skali

Informan 2: jau

Informan 3: jau skali sekitar 100m ini

Infoman 4: jau skali

Informan 5: jau kk. Ini sekitar 200 meter ke jalan ini kk

P: apakah di rumah ada tempat sampah? Jelaskan

Informan 1 : ada tempat sampah.

Informan 2 : ada tepat sampah,kalo su ponoh katong angka buang

Informan 3 : ada pake plastic saja to. Tampah sampah di tampah makan sendiri, di tampa masak sendiri.

Infoman 4 : ada thu.

Informan 5 : ada. Pake karung saja itu

P: apakah di rumah sering membuang sampah sembarangan? Jelaskan

Informan 1 : oh tidak, nga ada.

Informan 2 : seng ada

Informan 3 : seng ada lae.

Infoman 4 : seng isi di karung lansung pi buang di lestari sana.

Informan 5 : seng.kalo sampah dong taru di tempat samph

P: di manakah tempat buang sampah tersebut? Jelaskan.

Informan 1 : di jurang, di tebing-tebing

Informan 2 : di tempat sampah di depan

Informan 3 : di bak kuning yang di depan jalan itu..

Infoman 4 : di lestari sane.

Informan 5 : ada kolam 1 di belakang.dong buang di situ

P: dari manakah air yang sedang di minum? Jelaskan

Informan 1 : air rebusan di angkat dari air leden, airnya bagus ko.

*Informan 2 :*katong minum air dari sumur.ada sumur yang katong mandi, tapi ada sumur yang negri punya yang ktong minum itu akang dari gunung itu.

Informan 3 : air PAM. Paitua kerja di PAM jadi.

Infoman 4 : air dari sumur

Informan 5 : katong minum air galong

d. Pengetahuan

P: apakah bapak/bu pernah mendengar penyakit yang namanya ISPA? Jelaskan

Informan 1 : pernah dengar ko?

Informan 2 : ya perna dengar

Informan 3 : ya pernah

Infoman 4.: seng perna dengar bu.

Informan 5 : kalo penyakit itu b pernah dengar.tapi beta sengtau akang yangbagemana

P: apakah bapak / ibu tau tentang faktor -faktor yang menyebabkan bapak/ibu Mengalami ispa? Jelaskan

Informan 1 : biasanya mandi malam, masuk dingin, itu cepat serang batuk dan kalo sudah gitu, awalnya tengorokan rasa kering.

Informan 2 : tau, pkonya gatal-gatal di tengorokan to? Kalo makan tasalah.Makas es-es itu akang biking par gatal sudah.

Informan 3 : batuk, tengorokan gatal to, ada lender kalo batuk, terus ada ingus badan panas meriang.

Infoman 4 : beta seng tau

Informan 5 : kalo beta babatu begini par making siri lah telan air siri.

P: apakah tau cara mencegah terjadinya ispa? Jelaskan.

Informan 1 : saya uda nga mandi malam lagi.takutnya masuk dingin

Informan 2 : beta sudah larang anak dong jang bakar sampah di sini.

Informan 3 : beta suda mara dorang, seng bole bakar ban lae.

Infoman 4 : beta seng tau bu.

Informan 5 : beta ada mau stop makang siri ini

BAB VI

PEMBAHASA

A. Gambaran Keadaan Ventilasi yang Menyebabkan terjadinya Infeksi Saluran Pernapasan pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Passo

Berdasarkan pertanyaan terkait ventilasi. *Apakah di rumah ada ventilasi?* Maka di dapati bahwa *informan* nomor 1,2,3,4,5 mengatakan mereka memiliiki ventilasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan penulis di dapati bahwa Ventilasi sangat bermanfaat bagi kesehatan. Hal Ini di dukung oleh ILO (1991). Fungsi ventilasi adalah untuk menggerakan udara kotor dalam rumah atau di tempat kerja, kemudian di gantikan dengan udarah bersih.

Berdasarkan jawaban dari 5 informan terkait pertanyaan Nomor 2 *Berapa ukuran ventilasi tersebut?* Maka di dapati bahwa *Informan* 1,2,3,4,5 mengatakan mereka tidak tahu.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, di dapati bahwa Fungsi dari standar ini adalah untuk memastikan kualitas udara dalam ruangan dapat diterima oleh penghuni bangunan yang meminimalkan efek buruk bagi kesehatan. Hal ini di dukung oleh : Agusriyani, dkk (2019). Rumah yang luas ventilasinya tidak memenuhi syarat kesehatan akan mempengaruhi kesehatan Dan penghuni rumah, hal ini disebabkan karena proses pertukaran aliran udara dari luar ke

dalam rumah tidak lancar, sehingga bakteri penyebab penyakit ISPA yang ada di dalam rumah tidak dapat keluar.

Ventilasi juga menyebabkan peningkatan kelembaban ruangan karena terjadinya proses penguapan cairan dari kulit, oleh karena itu kelembaban ruangan yang tinggi akan menjadi media yang baik untuk perkembang biakan bakteri penyebab penyakit Inspeksi saluran pernapasan.

Berdasarkan jawaban dari 5 informan terkait pertanyaan Nomor 3. *Berapa banyak ventilasi yang di gunakan* ?. maka di dapati hasil bahwa : *Informan* nomor 1,2,4,5 mengatakan rumah mereka memiliki ventilasi kurang dari 10 Sedangkan *informan* Nomor 3, mengatakan ventilasih ada lebih dari 20 ventilasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis di dapati bahwa Jumlah ventilasi sangat penting untuk udarah bebas masuk keluar rumah. Berdasarkan kemenkes RI Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999, syarat ventilasi rumah sehat yaitu ≥ 10% dari luas lantai. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh sultan M adrianto dkk (2021) yang menujukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara ventilasi rumah dengan kejadian ISPA pada balita di Gampong Blang Muko dimana didapatkan nilai *p value* 0,032 < 0,05 dan nilai OR yaitu 2,590 yang artinya bahwa seseorang yang mempunyai ventilasi rumah kurang baik memiliki risiko akan mengalami ISPA 2,590 kali lebih besar di bandingkan dengan seseorang yang mempunyai ventilasi rumah dengan baik.

Berdasarkan jawaban dari 5 informan terkait pertanyaan Nomor 4. *Apakah ventilasih tersebut memakai penangkal debu?* Maka di dapati hasil bahwa *informan* nomor 1,2,3,4,5. Mengatakan ventilasih rumah mereka Tidak memiliki penangkal debuh.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis di dapati bahwa ventilasih yang memakai penangkal debuh berfungsi untuk menyaring udara kotor yang masuk ke dalam rumah.. Hal ini di dukung oleh. A Hidayat (2023) ventilasi udarah memiliki peran penting untuk menyaring serbuk sari, debu, maupun jenis iritasi lain yang terdapat di udarah. Apabilah tidak ada ventilasi maka kandung bahan yang ada di dalam udarah tidak akan bisa bersaing secara baik.

Berdasarkan jawaban dar 5 informan terkait pertanyaan Nomor 5.*Apakah Ventilasih ada debuh? jelaskan* Maka di dapat hasil bahwa *informan* nomor 1 mengataka tidak ada debuh, Sedangkan jawaban *informan* nomor 2,3,4,5 mengatakan ventilasih mereka ada debu.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, di dapati bahwa. Kebersihan ventilaih sangat penting agar debuh tidak masuk ke dalam rumah Hal ini di dukung oleh Kidange, J. I.(2019) Mengatakan bahwa fungsi ventilasi memiliki penangkal debuh adalah Membuat kualitas udarah di dalam rumah menjadi lebih sehat.Hal ini di dukung oleh Wijayanti R (2019) menyaring debu dari ventilasi udara memiliki peran penting untuk menyaring serbuk sari, debu, maupun jenis iritasi lain yang

terdapat di udara. maka kandung yang ada di bahan udara tidak akan bisa tersaring secara baik.

Berdasarkan jawaban dari 5 informan terkait pertanyaan Nomor 6 *ada berapa orang dalam satu kamar tidor? Jelaskan.* Maka di dapat hasil bahwa *informan* Nomor 1 dan 4 mengatakan tidor sendiri. Sedangkan *informan* Nomor 2 dan 5 mengatakan ada dua orang dalam 1 kamar. Sedangkan *informan* Nomor 3 mengaatakn Ada 3 orang dalam 1 kamar.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, di dapati bahwa Sanitasi fisik rumah harus diperhatikan. Hal ini di dukung oleh Hasil penelitian Asriati, dkk (2015) yang menunjukkan hasil jika kepadatan hunian dapat meningkatkan kelembapan akibat uap air dari pernapasan diikuti peningkatan Karbon Dioksida (CO2) ruangan, penurunan kadar oksigen, sehingga menimbulkan penurunan kualitas udara dalam rumah an menyebabkan daya tahan tubuh penghuninya menurun dan memudahkan terjadinya pencemaran gas atau bakteri kemudian cepat menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti ISPA.

Berdasarkan jawaban dari 5 informan terkait pertanyaan Nomor 7 *Berapa ukuran kamar tersebut?* Maka di dapat hasil bahwa *informan* Nomor 1,2,4 mengatakan ada sekitar 3x3 Sedaangkan *informan* Nomor 3 dan 5 mengatakan mereka tidak tahu.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, di dapati bahwa luas ruang tidur juga sangat perlu diperhatikan. Luas ruangan tidur yang dipersyaratkan adalah minimal 8 m^2 untuk maksimal 2 orang

penghuni (Depkes RI, 1999). Hal in di dukung oleh Ningrum (2015), hunian dengan tingkat kepadatan yang tinggi akan meningkatkan suhu dan kelembapan dalam ruangan akibat pengeluaran panas dari pernapasan penghuninya. Masyarakat di Desa Kalianget Timur yang memiliki kepadatan hunian kamar balita yang tidak sesuai denganpersyaratan kesehatan, sebaiknya sebisa mungkin mengatur ulang jumlah penghuni kamar tidur balita seperti ayah tidur di ruang tamu, untuk mencegah terjadinya ISPA pada balita.

B. Gambaran Kebiasaan Merokok yang Menyebabkan Terjadinya Inspeksi Saluran Pernapasan pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Passo.

Berdasarkan jawaban dari 5 informan terkait pertanyaan Nomor 8 *Apakah bapak /ibu merokok? Jelaskan*.? Maka di dapat hasil bahwa informan Nomor 1, 2, 3. Mengatakan mereka tidak merokok. Sedangkan *informan* Nomor 4 mengatakan merokok Dan *informan* Nomor 5 mengatakan hanya makan siri

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, di dapati bahwa Perilaku merokok adalah perilaku yang dinilai sangat merugikan. Di lihat dari berbagai sudut pandang baik bagi diri sendiri maupun orang lain yang ada disekitarnya. Hal ini di dukung oleh Alamyah, A, dan Nopianto, N. (2017). Perilaku merokok merupakan perilaku yang membakar salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, di isap atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau

bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotina tabacum, nicotina rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan dengan atau tanpa bahan tambahan.

Berdasarkan jawaban dari 5 informan terkait pertanyaan Nomor 9 *Apakah di dalam rumah ada yang merokok? Jelaskan.* Maka di dapat hasil bahwa informan Nomor 1 dan 3 mengatakan mereka tidak merokok. Sedangkan *informan* Nomor 2 dan 4 dan 5 mengatakan mereka merokok.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, di dapati bahwa.banyak warga di passo mengalami ISPA di karenakan fakor merokok. Hal ini di dukung oleh Fikriyah,S., Dan Subrijanto, Y(2012). Perilaku merokok adalah perilaku yang dinilai sangat merugikan di lihat dari berbagai sudut pandang baik bagi diri sendiri maupun orang lain yang ada disekitarnya.

Berdasarkan jawaban dari 5 *informan* terkait pertanyaan Nomor 10*. Dalam 1 minggu berapa bungkus yang di habiskan?* maka di dapati hasil bahwa Informan nomor 1 2 3 5 tidak merokok, sedangkan informan Nomor 4 mengatakan merokok.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, di dapati bahwa.merokok dapat merugikan diri sendiri dan orang banyak. Hal ini di kuatkan oleh Rahmah (2015) Kebiasaan merokok juga berpengaruh buruk terhadap kebiasaan (*habits*) seseorang, tetapi tidak secara langsung mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Sifat rokok yang terus menerus membuat ketagihan (*adiktif*), sehingga sangat sulit untuk

menghilangkan kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok menyebabkan seseorang menjadi lebih egois, hal ini dapat dibuktikan dengan kebiasaan merokok di tempat umum atau di ruang publik.

Perokok mengabaikan aturan-aturan (norma) dan dilarang merokok ditempat umum. Kebiasaan ini sangat merugikan kesehatan orang lain karena menjadikan mereka yang tidak mengkonsumsi rokok sebagai perokok pasif yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan perokok aktif.

Berdasarkan jawaban dari 5 informan terkait pertanyaan Nomor 11 *Dalam 1 hari berapa batang roko di habiskan? Jelaskan.* Maka di dapat hasil bahwa *informan* Nomor 1 ,2, 3, 5 mengatakan tidak ada, sedangkan i*nforman* nomor 4 mengatakan 1-2 batang merokok di habiskan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, di dapati bahwa menghisap rokok 1-5 batang rokok menyebabkan perubahan drastis dalam waktu satu jam, yang mengakibatkan peningkatan kadar asam lemak, epinefrin, gliserol bebas, aldosteron dan kortisol Hal ini di dukung oleh Hidayat A.,Gumilang G (2017) Satu batang rokok mengandung lebih dari empat ribu (4000) jenis bahan kimia berbahaya bagi tubuh. Empat ratus (400) diantaranya bisa menjadi racun, sedangkan 40 dapat berbahaya bagi kesehatan dan bersifat karsinogenik.

C. gambaran keadaan Lingkungan Rumah/ Pekerjaan yang menyebabkan terjadinya Inspeksi salurn pernapsaaan pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Passo.

Berdasarkan jawaban dari 5 *informan* terkait pertanyaan Nomor 12 *Apakah saat keluar rumah selalu mengunakan masker*? *Jelaskan* Maka di dapat hasil bahwa *informan* Nomor 1, 4, 5 pake, sedangkan jawaban nomor 2 dan 3 tidak.pake masker.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, di dapati bahwa Pencemaran udara adalah terganggunya unsur-unsur udara karena polutan yang bersumber dari asap industri, pesawat terbang, kendaraan bermotor, bau sampah, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dll. Hal ini di dukung oleh Sudarmadi et al (2001) bahwa salah satu penyebab kerusakan lingkungan karena di dominasi oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Masalah lingkungan hidup yang terjadi dapat dikatakan sebagai masalah moral, yang berhubungan dengan perilaku manusia yang akan menentukan baik buruknya kondisi suatu lingkungan**.**

Berdasarkan jawaban dari 5 informan terkait pertanyaan Nomor 13 *Apakah jika bapak/ ibu bersing selalu menutup hidung dengan tisu atau lenso? Jelaskan* Maka di dapat hasil bahwa *informan* Nomor 1, 2 mengatakan selalu mengunakan masker sedangkan *informan* nomor 3, 4, 5, mengatakan tidak mengunakan masker.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, di dapati bahwa Masker berfungsi untuk melindungi diri dari debuh dan mencegafh terjadinya menular penyakit. Hal ini di kuatkan oleh DinKes Denpasar

(2020) (COVID-19) menerapkan etika batuk dan bersing, tutup dengan mengunakan lengan atas bagian dalam atau tisu.

Berdasarkan jawaban dari 5 informan terkait pertanyaan Nomor 14. *Apakah jenis lantai rumah bapak/ibu terbuat dari permanen? Jelaskan* Maka di dapat hasil bahwa *informan* Nomor 1, 3, 4 rumah permanen, sedangkan informan nomor 2 mengatakn rumah stengah permanen, dan *informan* nomor 5 mengatakan rumah papan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, di dapati bahwa Rumah permanen dapat menimbulkan jumlah ispa yang sedikit di bandingkan rumah semi permanen.: Hal ini di dukung oleh Wulandhni (2019) Rumah permanen pada umumnya memiliki lantai, dinding, tingkat kepadatan sedangkan rumah dengan tipe semi permanen, dan tidak permanen kebanyakan kondisi fisiknya masih kurang memenuhi syarat kesehatan.

Berdasarkan jawaban dari 5 informan terkait pertanyaan Nomor 15 *Apakah dinding rumah terbuat dari bahan permanen? Jelaskan.* Maka di dapat hasil bahwa *informan* Nomor 1, 3, 4 mengatakan dinding permanen. Sedangkan *informan* nomor 2 mengatakan dinding stengah permanen, dan *informan* nomor 5 mengatakan rumah papan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, di dapati bahwa Rumah dengan diinding yang tidak memenuhi syarat mudah terppar penyakit ispa. Hal ini di dukung oleh Wulandhani s, dkk (2019) Besarnya risiko untuk terkena ISPA dapat dilihat dengan nilai OR = 5,294

yang artinya rumah dengan jenis dinding yang tidak memenuhi syarat memiliki risiko terkena ISPA sebesar 5,294 kali lebih besar dibandingkan dengan rumah yang kondisi dindingnya memenuhi syarat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aji (2008) di Kabupaten Cilacap yang menunjukkan bahwa kondisi dinding rumah yang dibuat secara tidak permanen berhubungan dengan terjadinya ISPA dimana nilai p = 0,017 dan OR =3,59. Sehingga dapat disimpulkan jenis dinding rumah yang dibuat secara tidak permanen dapat mempengaruhi kelembaban di dalam rumah dan kelembaban dapat mempengaruhui berkembangnya penyebab ISPA.

Berdasarkan jawaban dari 5 informan terkait pertanyaan Nomor 16 *Apakah bahan bakar di dapur menghasilkan asap? Jelaskan.* Maka di dapat hasil bahwa *informan* Nomor 1, 2 3, 4 mengatakan tidak. Sedangkan informan nomor 5 mengatakan iya

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, di dapati bahwa Asap yang berasal dari bahan bakar membuat penghuni rumah lebih cepat terserang penyakit pernaparan. Hal ini di dukung oleh Lula. Banyak wanita tak menyadri bahwa adanya bahaya dari asap hasil memasak di dapur. Wanita di indnesia sering kalih memasak yang penuh dengan asap seperti mengoreng. Padahal menurut lula dampaknya bisa dari sekedar batuk-batuk saat menghirup asap yaaang berasal dari dapur.Lula mengatakan asaap termasuk oksidan yang dapat merusak sel dalam tubuh jika di hirup dalam jangka panjang.

Berdasarkan jawaban dari 5 informan terkait pertanyaan Nomor 17. *Apakah lokasi rumah dekat dengan jalan rayah? Jelaskan*. Maka di dapat hasil bahwa *informan* Nomor 1, 2, 3, 4, 5.mengatakan jauh.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, di dapati bahwa Tidak ada hubungan antara jarak rumah dengan kejadian ISPA. Hal ini di dukung oleh Wulandari S.dkk (2019) mengatakan bahwa Jarak rumah yang berdekatan dengan jalan raya memiliki nilai OR sebesar 1,167. Hal ini berarti bahwa rumah yang dekat dengan jalan raya mempunyai kemungkinan 1,167 kali lebih besar untuk mengalami ISPA dibandingkan dengan rumah yang jauh dengan jalan raya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih (2016), berdasarkan hasil analisisn dengan uji chi square diperoleh nilai *p* sebesar 0,014 yang menunjukkan bahwa secara statistik terdapat hubungan yang bermakna antara jarak tempat tinggal dengan jalan raya dengan kejadian ISPA pada anak di Kecamatan Sragen. Sedangkan parameter kekuatan hubungan didapatkan nilai OR = 3,09 dengan CI 95% antara 1,24-7,70. Hal ini berarti bahwa anak yang rumahnya dekat dengan jalan raya mempunyai kemungkinan 3,09 kali lebih besar untuk mengalami ISPA dibanding dengan anak yang tempat tinggalnya jauh dengan jalan raya.

Berdasarkan jawaban dari 5 *informan* terkait pertanyaan Nomor 18 *Apakah di rumah ada tempat sampah? Jelaskan.* Maka di dapat hasil bahwa *informan* No 1, 2, 3, 4, 5. Memiliki tempat sampah.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan Maka penulis mengambill kesimpulan bahwa tempat sampah sangat penting untuk menjaga kebersihan di dalam rumah. Hal ini di dukung oleh. Dewi R Nugraha-eProceedings (2019) Tempat sampah adalah tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik. Di dalam ruangan, tempat sampah umumnya di simpan di dapur untuk membuang sisah keperluan dapur seperti kulit, buah atau botol. Ada juga tempat sampah khusus kertas yang di gunakan.

Berdasarkan jawaban dari 5 informan terkait pertanyaan Nomor 19. *Apakah di rumah sering membuang sampah sembarangan?* Jelaskan. Maka di dapat hasil bahwa *informan* Nomor 1,2,3,4,5 Tidak membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara dari 5 *informan* Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kebersihan dalam rumah sangat penting bagi penghuni untuk mencegah terjadinya ispa. Hal ini di dukung oleh Sumijatun, (2002) perilaku seseorang terhadap pemeliharan lingkungan seprti perilaku hidup bersih, perilaku seseorang terhadap perilaku kesehatan di mana respon terhadap lingkungan sebagai penentu kesehatan manusia.

Berdasarkan jawaban dari 5 *informan* terkait pertanyaan Nomor 20 *Di manakah tempat buang sampah tersebut? Jelaska.* Maka di dapat hasil bahwa informan Nomor 1,2,3,4,5 mereka membuanng sampah di tempat sampah umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, di dapati bahwa tempat sampah umum sangat berfungsi untuk mencegah terjadinya penyakit Hal ini di dukung oleh penelitian sumijatun (2002) Dari hasil penelitan menujukan bahwa keadaan lingkungan rumah/pekerjaan responden yang berdebu 15 responden (50%),lingkungan kotor 8 responden (27%),dan lingkungan bersih 7 orang (23%), Keadaan penerangan dirumah responden adalah terang 25 responden (83%), dan remang- remang 5 responden (17%),Cara mengolah sampah/pembuangan sampah adalah sampah di bakar10 responden (33%), dan sampah di timbun 20 responden (67%), Kebiasaan responden dalam membersihkan lingkungan rumah yaitu 1 kali seminggu 18 responden (60%),dan 1 kali sehari 12 responden (40%), Serta rumah responden yang berlantaikan semen 17 responden (57%),berlantaikan tanah 5 responden (17%), dan berlantaikan jubin 8 responden.

Berdasarkan jawaban dari 5 informan terkait pertanyaan Nomor 21. *Dari manakah air yang sedang di minum? Jelaskan.* Maka di dapat hasil bahwa *informan* Nomor 1, 3, 5,mengatakan mereka minum air leden. Sedangkan informan nomor 2, 4, mengatakan mereka minum air dari sumur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengambil kesimpulan bahwa warga di passo banyak memiliki air yang sehat. Hal ini di dukung oleh

penemuan Suripin (2002) mengatakan Air yang aman sehat dan baik untuk di minum adalah tidak berwarna, tidak berbau dan ttidak terpapar sinar mata air,dengan rasa yang segar

D. Untuk mengetahui gambaran Pengetahuan yang menyebab kanterjadinya Inspeksi saluran pernaapasan pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Passo.

Berdasarkan jawaban dari 5 *informan* terkait pertanyaan Nomor 22 *Apakah pernah dengar penyakit yang namanya ISPA? Jelaskan.* Maka di dapat hasil bahwa *informan* Nomor 1, 2 3, 5. Mengatakan Perrnah degar, sedangkan informan nomor 4 mengatakan tidak pernah dengar

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, di dapati bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, maka ia akan lebih muda mengerti tentang carah mencegaah terjadinya ispa. Hal ini di dukung oleh penelitian menurut Notoadmojo, (1993) mengatakan semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka semakin mudah menerima informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki dan semakin bertambah umur, tingkat kematangan seseorang akan lebih matang dalam berpikir, bekerja serta memperoleh banyak pengalaman. Pengalaman merupakan sumber pengetahuan sehingga semakin banyak pengalaman yang di miliki seseoraang informasi yang di dapatkan tersebut semakin banyak.

Berdasarkan jawaban dari 5 informan terkait pertanyaan Nomor 23. *Apakah bapak / ibu tau tentang faktor-faktor yang menyebabkan bapak/ibu Mengalami ispa? Jelasan* Maka di dapat hasil bahwa informan Nomor 1,2,3,5 mengetahui, sedagkan informan nomor 4 tidak mengetahui

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, di dapati bahwa semakin tinggi penddidikan seseorang, maka semakin mudah memahami tentang penyakit yang di alami, dan semakin mudah untuk di Hindari. Hal ini di dukung oleh Lozano et al., (2011), menyatakan bahwa seseorang yang berpendidikan tinggi lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih termotivasi untuk terlibat dalam lingkungan yang bertanggung jawab perilaku karena mereka lebih menyadari potensi kerusakan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Julina, (2016), bahwa seiring dengan meningkatnya tentang pengetahuan, akan berdampak pada sikap dan karena karena pengetahuan, sikap dan perilaku saling berhubungan.

Berdasarkan jawaban dari 5 *informan* terkait pertanyaan Nomor 24. *Apakah tau cara mencegah terjadinya ISPA? Jelaskan.*

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, di dapati bahwa *informan* nomor 1,2,3,5 mengetahui sedangkan informan nomor 4 tidak mengetahui.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, pengetahuan sangat penting bagi lansia. Hal ini di dukung oleh Sumijatun, (2002) Semakin Tinggi Pengetahuan Seseorang Maka Ia Akan

Mengerti Tentang Penyakit Tersebut Dan Berusaha Untuk Menghindarinya.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang di angkat yaitu untuk mengetahui gambaran Faktor Penyebab Kejadian Inspeksi saluran pernafasan pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Passo. penelitian ini di lakukan dengan metode penelitian fenomenologi dengan teknik pengumpulan data secara wawancara dengan 5 *informan.* Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikit :

1. Berdasarkan hasil wawancara jawaban terhadap 5 para *informan* di dapati bahwa faktor ventilasi yang mempengaruhi masyarakat terkontaminasi penyakit ISPA di karenakan ventilasi tidak memenuhi syarat dan banyak debuh.
2. Berdasarkan hasil wawancara jawaban dari 5 para *informan* di dapati bahwa faktor kebiasaan merokok yang menyebabkan masyarakat terkontaminasi ISPA di karenakan mereka yang tidak mengerti tentang aaturan merokok, sehingga membuat masyarakat terkontaminasi penyakit ISPA.
3. Berdasarkan hasil wawancara jawaban dari 5 para *informan* di dapati bahwa faktor lingkungan/pkerjaan yang dapat membuat mereka terkontaminasi penyakit ISPA. di karenakan mereka tidak memakai masker saat beraktifitas di luar rumah.

4. Berdasarkan hasil wawancara jawaban dari 5 para *informan* di dapati bahwa faktor pengetahuan yang membuat masyarakat yang berdomisilih di wilayah kerja puskesmas passo terkontaminasi penyait ispa. Di karenakan masyarakat belum memahami tentang protokol kesehatan yang benar.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan yang di lakukan dapat di sarankan bahwa

1. Di harapkan *informan* dapat memahami tentang ukuran ventilasi dan dapat membersihkan degan baik. Agar kedepanya tidak terkontaminasih penyakit ISPA
2. Di harapkan agar *informan* jangan merokok dan bisa menjaga jarak dari orang yang merokok, agar tidak terkontaminasi penykit ISPA
3. Di harapkan *informan* harus menjaga kebersihan di lingkungan dan selalu memkai masker saat keluar rumah Agar tidak terkontaminasi penyakit ispaaa
4. Di harapkan *informan* bisa Mengerti dan memahami penuh bagaimana cara mencegah agar tidak terkontaminasi penyakit ispa.

DAFTAR PUSTAKA

Adriana,Mardian, Sri, & Yanti. (2019). Penagaruh senam, Osteoporosis terhadap penurunan nyeri Muskuloskeletal pada lanjut usia.' *Seminar nasional Mahasiswa Bima*. Vol 1 No 1. Diakses dari https://semnas.tsb.c.id/index.php/prosiding/article/view/44 pada tanggal 5 oktober 2023

Agusriyani, WON, & Aliah, M. (2019). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Penyakit ISPA. *Jurnal Keajaiban Kesehatan Masyarakat* Vol 2 No 1. Di akses dari http://doi.org/10.36566/mjph.Vol2.1.35 pada tanggal 5 oktober 2023

Alamsyah, Agus & Nopianto Nopianto. (2017). Diterminan perilaku merokok pada remaja. *Jurnal Endurance vol 6.* di akses dari http://ejournal.lldikti10.id/index.php/endurace/article/view/1372 pada tanggal 5 oktober 2023

Amalia,Ary Nahdiyani,dkk. (2021). Evaluasi pengunan antibiotic pasien infeksi saluaran pernapasan akut (ispa) pada anak. *Media informasi penelitian kabupaten semarang.* Vol 5 No 1. Diakses dari https://journal.sinov.id/inde.php/sinov/article/download/556/482 pada tanggal 5 oktober 2023

Aru W, Sudibyo. (2006). *Buku Ajar Ilmu Penyakit dalam.* Edisi – 4. Jakarta : FKUI.

Asrun S. (2010). *Faktor Resiko Kejadian Infeksi Saluran pernafasan akut* . [Skripsi] Universits Sumatera Utara

Budiyanto H (2003). Manfaat pengunaan metoda konsoladaritasi tanah dalam rangka penataan wilayah perkotaan. Jurnal Arsitektur. Universitas merdeka malang. Di akses dari http://jurnal.unmer.ac.ad/index.php/jam/article/1956 pada tanggal 5 oktober 2023

Dekawati, Wahyu,.Rustiningsih and Dwisarbini. (2014). *Hubungan Status Gizi dengan Kejadian ISPA dan Diare pada Lansia.* [Skripsi]. Univrsitas Muhamadiyah Surakarta.

Depisa D.(2022) *Hubungan Kondisi Lingkungan Dengan Kejadian Ispa Pada Belita.* [Skripsi]. Universitas islam Kalimantan.

Dermojo dan mortono. (2006). *Hubungan status gizi dengan kejadian ispa pada lansia*. {Skripsi} Universitas muhammadiyah surakarta. Di akses https://eprints.ums.ac.id/32134/7/naskah%20publikasi.pdf pada tanggal 5 oktober 2023

Fikriyah,S. & Subrijanto. (2012). Faktor-Faktor yang mempegaruhi perilaku merokok *Jurnal stikes.* Vol 5 No 1. Di akses dari http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/stikes/article/download/18472/18286, pada tanggal 5 oktober 2023

Hermawan, Iwan. (2019). *Metodologi penelitian pendidikan kualitatif, kuantitatif dan Mixed Methode*. Hidayatul Quran Kuningan

Huda, N. (2021). *Hubungan Kondisi Fisik Rumah Dan Keberadaan Perokok Dalam Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Lansia*. universitas islam kalimantan. Di akses dari http://eprints.uniska-bjm.ac/id/id/eprint8818 pada tanggal 5 oktober 2023

Handini,Ratna (2021). *Hubungan Tingkat Kemandirian Aktivitas Hidup Sehari-Hari Dengan Kulitas Hidup Pasien Lanjut Usi* [Skripsi] Ppni Mojokerto.

Handayani,Vivin Affrilina, dkk. (2022). Tingkat kecemasan pasien yang memiliki penyakit komorbid terhadap penularan covid -19 Universitas stikes bina sehat mojokerto. Di akses pada http://repositori.stikes-ppni.ac.id/handle/123456789/1120?show=ful pada tanggal 5 oktober 2023

Junisa,Nufitaainaiyah. (2023) *Faktor Di Terminan Praktik Merokok Kepalah Keluarga* universitas Siliwangi.

Kristiningtyas, Y.W., dkk (2021). *Pngaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap dan pemanfaatan senam lansia* Jurnal keperawatan.Vol.10. No 2. Di Akses https://jurnal.akpergshwng.ac.id/index.php/kep/article/view/4/5 pada tanggal 5 oktober 2023

Khusuma,yudha Laga Hadi. (2010). Tingkat ketergantungan lansia dalam aktifitas Hidup sehari hari. *Jurnal Ilmiah Kesehatan* Vol 2 No 1. Di akses https://ejournal.stikesmajapahit.ac.id/index.php/HM/article/view14 pada tanggal 5 oktober 2023

Maula,A.M.N.(2020). Hubungan aktifitas spiritual dengan tingkat kecemasan pada lansia, {skripsi} Universitas muhamadiyah surabaya. Di akses http://repository.um-surabaya.ac.id/5734/1/PENDAHULUAN.pdf pada tanggal 5 oktober 2023.

Muhammar S. (2023). TOLERANSI BERAGAMA DALAM TRADISI TAPAKALI KUMKUM PADA. {skripsi} university islam state. Di akses http://repository.uinsaisu.ac.id/18697/ pada tanggal 5 oktober 2023.

Mujid, Muhammad zydan dkk. (2022) *'ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA TN.M DENGAN ANGGOTA KELUARGA MENGALAMI GANGUAN SISTEM PERNAPASAN:* universitasislam sultan agung semarang. Di akses pada http://repository.unissulac.id/2629/ pada tanggal 5 oktober 2023.

Marleni,ER Lily et al (2022) .Penanganan (ispa) pada anak *Vol* 5 No 1. Di akses http://ejurnalmalahayati.ac.ai/index.php/artichle/view/5226 pada tanggal 5 oktober 2023

Muttaqin. (2008).*Buku ajaran Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem Pernafasan* . Jakarta: Erlangga. Di akses http://onesearch.id/Record/IOS13415. pada tanggal 5 oktober 2023

Martinus Ruku . (2014). Survey faktor-faktor yang mendukung terjadinya ispa pada lansia. *Jurnal Info Kesehatan*. Vol 12 No 1. Di akses https://jurnal.poltekeskupang.ac.index.php/infokes/article/download/38/39 pada tanggal 5 oktober 2023

Narul,Adnan Faris, et, al. (2023) Hubungan atara durasi batuk pilek dengan kemampuan Motorik kasar pada Anak Anak."*fisio Journalf :Vol 2 No 1*. Di akses http://.jurnal.aiska-university.ac.id/index.php/physio/article/view/1108 pada tanggal 5 oktober 2023

Narmawan, Narmawan, Yuniwidya, dkk.' (2020) Studi komporatif peberian susu formulah dan ASI eklusif terhadap kejadian ispa bayi umur 0-6 bln.' *Jurnal of Holistic nursig science*. Vol 7.No 2.Di akses http://journal.unimma.ac.ad/index.php/nursing/article/view/3129

pada tanggal 5 oktober 2023

Natoamodjo (2010). *Motodologi penelitian kesehatan*. Jurnal ilmia kesehatan Vol 7 no 1.

Nurhafika Nurhafika. (2020) *Hubungan pemilihan makanan dengan kejadian hipertensi pada lansia* Universitas pahlawan tuanku tambusai.di akses https://repository.universitaspahlawan.ac.id/262/ pada tanggal 5 oktober 2023

Nugroho. (2000). *Keperawatan Komunitas*. Jakarta: Salemba medika Natoadmojodjo.

Ninda Assyfa, Ninda. ,(2022) *Asuhan Keperawatan Pola Nafas Tidak Efektif Pada Anak Yang Mengalami Infeksi Saluran Pernafasan akut* {KTI}. Universitas Sultan Agen Tirtayasa. Di akses pada http://eprints.untirta.ac.id/15182 pada tanggal 5 oktober 2023

Oktoviandini, dkk. (2023). Review potensi pengembangan produk hasil ikan air tawar untuk meningkatkan kecukupan protein pada lansia. universitas katholik soegijapranata semarang. Di akses pada http://repository.unika.ac.id/31280/1/16.11.0170-AURELIA%VIOLITA%20VINCI%200KTAVIAND... pada tanggal 5 oktober 2023

Prastika, Yolanda. (2022). *Pengaruh edukasi melalui (Lembar balik vaksin covid) terhadap pengetahuan dan sikap tentang vaksin covid-19 pada pra lansia.* poltekes kemenkes Bengkulu.di akses http://repository.poltekkesbengkulu.ac.ad/id/eprint2359 pada tanggal 5 oktober 2023

Putra, Yuhendri, dan Sekar Sri Wulandari. (2019) ."Faktor Penyebab ISPA." *Jurnal Kesehatan* Vol 10.No 1.

Ratminasari, Dian. (2014). *Hubungan Dukungan Sosial Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia* Diss. University of Muhammadiyah Malang.

Sukarto, Riska Cahya Dkk. (2016). Hubungan orang tua dalam pencegahan ispa dengan kekembuhan ispa pada belita. *Jurnal keperawtan* Vol 4. No 1. Di akses https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jkpp/article/view/19911 pada tanggal 5 oktober 2023

Suri D. R. (2021). Upayah pemerintah dalam upaya kesejatheraan lanjut usia {skripsi} Universitas lampung. Di akses pada http://diglib.unila.ac.id/67722/3/skripsi%20tanpapebahasan%20Desi%20Ratna%20... pada tanggal 5 oktober 2023

Suijatun (20114). Survey faktor faktor yang mendukung terjadinya ISPA pada lansia. *Jurnal info kesehatan* Vol 12 No 1.

SIDOMUKTI, P, K. U. T. D. (2013). Studi kadar debu kapas di udara pada pengolahan kapas. *Jurnal* Universitas Dian Nuswantoro semarang. Diakses pada http://eprints.dinus.ac.id/6500/1/jurnal1440.pdf. pada tanggal 5 oktober 2023

Wimala, M., & Winardo, K. (2023). Kajian Kebutuhan Ventilasi Alami Ruangan pada Bangunan Gedung. Jurnal index Vol 17 No 2. Di akses Pada https://rekayasasipil.ub.ac.id/index.php/rs/article/view/932 pada tanggal 5 oktober 2023

YAYASAN BANGUN PRIMA PERSADA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PASAPUA AMBON
Jl. Suli Raya, Telp. (0911) 353317: Email: pasapuaambon@gmail.com
Izin: Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 172/D/O/2009
Rekomendasi Depkes R.I Nomor : HK/05/I/II/4/4611/2009

Nomor : 580/STIKES/PA/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : ***Permohonan Pengambilan Data Awal Penelitian***

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Ambon
di
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan dilaksanakan proses penyusunan Proposal yang merupakan persyaratan lulus bagi mahasiswa semester VIII Prodi S1 Ilmu Keperawatan STIKES Pasapua Ambon TA.2022/2023, maka kami mohon kesediaan Bapak /Ibu untuk dapat mengijinkan mahasiswa kami yang namanya tersebut dibawah ini untuk melakukan data awal pada instansi yang dipimpin oleh Bapak/Ibu:

Nama	: Leunardus Djerol
NIM	: P1911142
Judul Proposal	: Upaya penanganan ispa pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Passo
Lokasi	: Puskesmas Passo
Rencana Pelaksanaan	: Selasa, 21 Juli 2023- Selesai

Demikian penyampaian kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Suli, 21 Juli 2023
Mengetahui ,
Wakil Ketua I Bidang Akademik

Asriaty Dinopawe, S.ST.,M.Keb
NIDN . 1221099001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Puskesmas Passo
2. Ketua Yayasan Bangun Prima Persada Ambon
3. Arsip

SURAT PERSETUJAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawa ini :

Inisial Nama : Ny. J. H.

Umur : 40 THn

Jenis kelamin : P

Alamat : Passo klinik mata.

Dengan ini saya mengatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian saudara Leunardus Djerol,selaku mahasiswa sekolah tinggi ilmu keperawatan pasapua ambon yang berjudul "**Faktor penyebab ispa padaa lansia di puskesmas passo**

Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak berakibat dampak negativ bagi saya dan pihak instansi tempat peneliti kulia sehingga jawaban yang saya berikan adalah sebenarnya

Ambon.....2023

J.B.Maria.....

iii

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Leunardus Djerol

Jenis kelamin : Laki - Laki

Alamat : wayari

Agama : kristen protestaan

Saya mahasiwa program studi ilmu keperawatan.sekolah tinggi ilmu keperawatan pasapua ambon yang akan melakukan penelitian dengan ***judul " Faktor penyebab ISPA pada lansia di puskesma passo***

Dengan ini saya mohon kesediaan saudara untuk menjadi infoman untuk penelitian ini,dengan mendatangani lemba persetujuan informan,saya akan menjaga kerahasiaan identitas saudara dan tidak mempublikasikan kepada masyarakat umum.

Wayari.....2023

peneliti.

Leunardus Djerol

iii

PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Telp. 0911-351579
KodePos : 97126 website: dpmptsp.ambon.go.id email : dpmptsp@ambon.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 1348/DPMPTSP/XI/2023

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 346 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Terintegrasi Secara Online Single Submission dan Non Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
4. Berdasarkan Surat Pengantar Izin Penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor070/1916/BKBP/2023.

Menimbang : Surat Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Ambon Nomor: 1099/STIKES/PA/XI/2023 Tanggal 02 November 2023

Kepala DPMPTSP Kota Ambon, memberikan izin kepada :

Nama : **LEUNARDUS DJEROL**
Identitas : Mahasiswa
Untuk : Gambaran Penyebab Kejadian ISPA Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Passo
1. Lokasi Penelitian : Puskesmas Passo
2. Waktu Penelitian : 08 (Delapan) Hari

Sehubungan dengan maksud diatas, maka dalam melaksanakannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku;
b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan;
c. Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian;
d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian;
e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung;
f. Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat;
g. Surat Rekomendasi ini berlaku dari Tanggal 02-11-2023 s/d 13-11-2023 serta dapat dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal 06 November 2023

A.n. WALIKOTA AMBON
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. Pieter Sainima, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640222 199203 1 011

PEMERINTAH KOTA AMBON
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jalan Sultan Hairun No. 1 Telp. (0911) 351579
AMBON - 97126

TANDA TERIMA
DOKUMEN PERMOHONAN IZIN IJIN REKOMENDASI PENELITIAN
NO. REG : 2023070299

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Brian Pattiwael
Npp :
Jabatan : Customer Service

Telah menerima dokumen / berkas permohonan izin Ijin Rekomendasi Penelitian
Pemohon : LEUNARDUS DJEROL
Alamat : Jl. Suli Raya
Kecamatan :
Kelurahan :
Kota : Kota Ambon

Copy berkas terlampir

Yang Menyerahkan,			Yang Menerima		
Nama	:	LEUNARDUS DJEROL	Nama	:	Brian Pattiwael
Jabatan	:		Nip/Npp	:	
No. Telp/HP	:	082239421413	Jabatan	:	Customer Service

Check List *)

No.	Jenis Dokumen Kelengkapan	Lengkap
1	Surat Pengantar/Permohonan dari yang bersangkutan (Perguruan Tinggi, Lembaga Survey dan Sejenisnya);	Ya
2	Proposal Penelitian/Skripsi dan sejenisnya;	Ya
3	Fotocopy KTP yang melakukan penelitian;	Ya
4	Meterai Rp.6000, mengisi surat pernyataan di atas meterai.	Ya

*Cek Status Proses Ijin melalui **http://simantapcek.ambon.go.id**

No	Pertanyaan	ada	tidak
	Ventilasi		
1	*Apakah di rumah ada ventilasi ? jelakan.*		
2	*Apakah di rumah ada ventilasi? jelakan.*		
3	*Berapa banyak ventilasi yang di gunakan ?. jelaskan.*		
4	*Apakah ventilasi tersebut memakai penangkal debu? Jelaskan.*		
5	apakah Ventilasi ada debuh ? Jelaskan.		
6	berapa orang dalam satu kamar tidor? Jelaskan.		
7	*Berapa ukuran kamar tersebut? Jelaskan.*		
	Kebiasaan merokok		
8	*apakah bapak / ibu merokok? Jelaskan.*		
9	*apakah di dalam rumah ada yang merokok? Jelaskan.*		
10	*dalam 1 minggu berapa bungkus yang di habiskan? jelaskan*		

11	dalam 1 hari berapa batang roko di habiskan? Jelaskan		
	Lingkungan pekerjaan		
12	*apakah saat keluar rumah selalu mengunakan masker?* *Jelaskan*		
13	*apakah jika bapak/ ibu bersin selalu menutup hidung dengan tisu atau lenso?* *Jelaskan*		
14	*apakah jenis lantai rumah bapak/ibu terbuat dari permanen?* *Jelaskan*		
15	*apakah dinding rumah terbuat dari bahan permanen?* *Jelaskan*		
16	*apakah bahan bakar di dapur menghasilkan asap?* *Jelaskan.*		
17	*apakah lokasi rumah dekat dengan jalan rayah?* *Jelaskan*		
18	apakah di rumah ada tempat sampah? Jelaskan.		
19	apakah di rumah sering membuang sampah sembarangan? Jelaskan		
20	di manakah tempat buang sampah tersebut? Jelaskan.		

21	*dari manakah air yang sedang di minum?* *Jelaskan*		
	Pengetahuan		
22	*apakah bapak/bu pernah mendengar penyakit yang namanya ISPA?* *Jelaskan*		
23	*apakah bapak / ibu tau tentang faktor -faktor yang menyebabkan bapak/ibu Mengalami ispa?* *Jelaskan*		
24	*apakah tau cara mencegah terjadinya ispa?* *Jelaskan*		

YAYASAN BANGUN PRIMA PERSADA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PASAPUA AMBON
Jl. Suli Raya, Telp. (0911) 353317: Email: pasapuaambon@gmail.com
Izin: Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 172/D/O/2009
Rekomendasi Depkes R.I Nomor : HK/05/I/II/4/4611/2009

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PASAPUA AMBON

Nama : .....
NIM : .....
Pembimbing : .....
Judul Skripsi : .....

No	Hari/Tanggal	Materi	Saran	Paraf Pembimbing
1	Senin, 13/11 2023	Substansi dan Sistematika	- Perbaiki teknik pengetikan BAB V - Perbaiki teknik pengetikan dan penggunaan Variabel pada BAB VI - Perbaiki BAB VII	
2.	Rabu, 15/11 2023	Substansi dan Sistematika	- Perbaiki Ukuran margin serta batas kiri - kanan - Perbaiki teknik pengetikan BAB VI - Perbaiki BAB VII	

Catatan :
1. *Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi*
2. *Lembar ini harus dilampirkan pada proposal dan skripsi*

YAYASAN BANGUN PRIMA PERSADA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PASAPUA AMBON
Jl. Suli Raya, Telp. (0911) 353317: Email: pasapuaambon@gmail.com
Izin: Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 172/D/O/2009
Rekomendasi Depkes R.I Nomor : HK/05/I/II/4/4611/2009

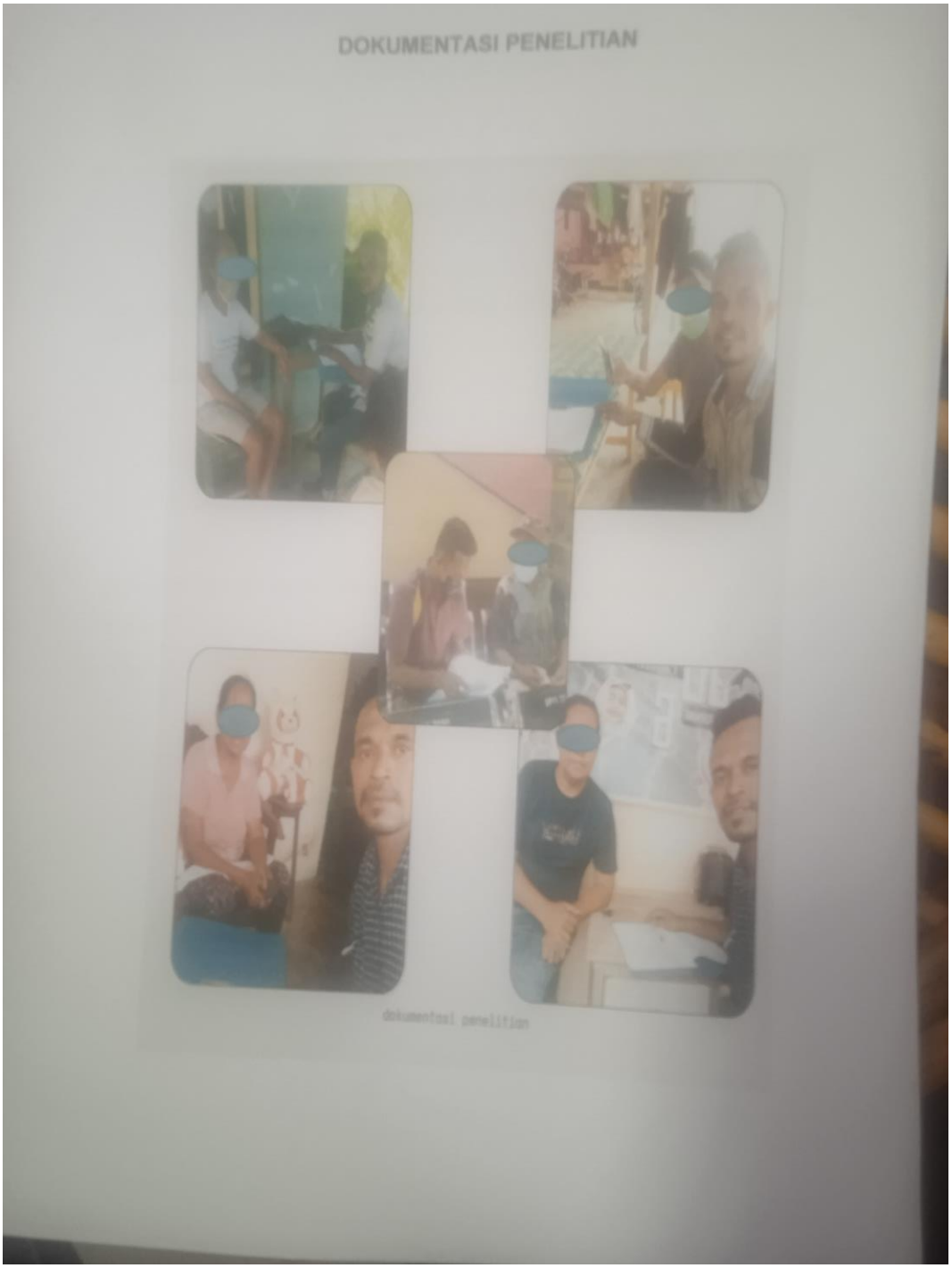
LEMBAR KONTROL PERSYARATAN SEMINAR SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
STIKES PASAPUA AMBON

NAMA : LEONARDUS DJEROI
NIM : P. 1911142

NO	KATEGORI	KETERANGAN	TTD (Stempel)
1.	Pelunasan SPP	Lebo	Ketua Bidang Keuangan Ma'sum Amah Tuhurua, S.Kep.Ns.M.Kes
2.	Pelunasan SP	Tidak Ada	Bidang Akademik Ashadi Nurdin Pakaya, S.ST., M.Kes
3.	Pelunasan Praktik	Lebo	Ketua Bidang Keuangan Ma'sum Amah Tuhurua, S.Kep.Ns.M.Kes
4.	Pelunasan Seminar Proposal		Bidang administrasi & Keuangan
5.	Pelunasan Seminar Hasil		Bidang administrasi & Keuangan
6.	Laporan Praktik Lapangan	lengkap	Perpustakaan [illegible]
7.	Laporan Praktik Klinik	- Dua	Perpustakaan [illegible]
8.	Ijasah ,Akte ,KTP	lengkap	Perpustakaan [illegible]

Catatan:
1. *Wajib diperlihatkan saat pengambilan surat permohonan pembimbing*
2. *Wajib diperlihatkan sebelum seminar proposal dan hasil*

DOKUMENTASI PENELITIAN



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PASAPUA AMBON
Jl. Suli Raya, Telp. (0911) 353317: Email: pasapuaambon@gmail.com
Izin: Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 172/D/O/2009
Rekomendasi Depkes R.I Nomor : HK/05/I/II/4/4611/2009

KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Unit Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Pasapua Ambon Menyatakan bahwa:

Nama :

NIM :

Prodi :

Tahun Masuk :

Alamat :

Telah menyelesaikan semua Administrasi piminjaman pada Perpustakaan (STIKES) Pasapua Ambon.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suli,
ka ,Perpustakaan

Thedy Wailaruno,S.Sos